

Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Praca dyplomowa inżynierska

Sieci neuronowe do analizy rytmu oddechowego

Neural networks for respiratory rhythm analysis

Autor: Maciej Łukasiewicz (197865)

Promotor: dr hab. inż. Julian Szymański

Gdańsk 2026

Wersja robocza — szkic pracy.

Streszczenie

Praca dotyczy bezkontaktowego pomiaru rytmu oddechowego i tętna przy użyciu radaru. W ramach części implementacyjnej zbudowano dwa niezależne tory pomiarowe: niskokosztowy radar dopplerowski HB100 (10,525 GHz) wraz z zaprojektowanym od podstaw analogowym układem kondycjonowania sygnału oraz radar impulsowo-koherentny Acconeer A121 (60 GHz) pracujący na surowych danych Sparse IQ. Opracowano algorytmy estymacji częstości oddechu i tętna oparte na analizie fazy sygnału odbitego, aplikację desktopową do akwizycji i podgądu na żywo oraz zestaw narzędzi do analizy offline. Przeprowadzono kontrolowany eksperyment porównujący trzy soczewki dielektryczne (hiperboliczną, FZP i płaską pokrywę) oraz wpływ folii aluminiowej naklejonej na klatkę piersiową (36 nagrań). W części eksperymentalnej system zastosowano do całonocnego monitoringu snu, porównując wyniki z zegarkiem Garmin Fenix 7.

[TODO: Uzupełnić streszczenie o wyniki końcowe sieci neuronowych, gdy powstaną.]

Słowa kluczowe: radar dopplerowski, radar impulsowo-koherentny, rytm oddechowy, parametry vitalne, HB100, Acconeer A121, analiza snu, sieci neuronowe.

Spis treści

Streszczenie	1
1 Wstęp	8
1.1 Motywacja	8
1.2 Cel i zakres pracy	8
1.3 Struktura pracy	9
I Przegląd literatury i istniejących rozwiązań	10
2 Bezkontaktowy pomiar parametrów vitalnych	11
2.1 Mierzone parametry i ich zakresy fizjologiczne	11
2.2 Motywacja kliniczna	11
2.3 Klasyczne metody kontaktowe	11
3 Radarowe metody pomiaru parametrów vitalnych	13
3.1 Radary dopplerowskie fali ciągłej (CW)	13
3.2 Radary FMCW	13
3.3 Radary impulsowo-koherentne (PCR)	14
3.4 Radary UWB	14
3.5 Porównanie torów HB100 i A121	14
3.6 Odbicie, transmisja i tłumienie w materiałach	15
3.7 Soczewki dielektryczne i kształtowanie wiązki	16
4 Metody niradarowe	17
4.1 Czujniki inercyjne (IMU)	17
4.2 Metody optyczne	17
4.3 Urządzenia nasobne jako źródło porównania	18
4.4 Rozwiązania komercyjne	18
5 Uczenie maszynowe w analizie sygnałów oddechowych	19
5.1 Klasyczne podejścia oparte na cechach	19

5.2	Sieci neuronowe dla sygnałów jednowymiarowych	19
5.3	Klasyfikacja faz oddechu	19
5.4	Dostępne zbiory danych	19
II	Zbudowany system pomiarowy	20
6	Architektura systemu i przebieg prac	21
6.1	Ogólna architektura	21
6.2	Przebieg prac i ewolucja projektu	21
7	Radar dopplerowski HB100	23
7.1	Moduł HB100 — zasada działania	23
7.2	Problem: amplituda sygnału wyjściowego	24
7.3	Zaprojektowany analogowy front-end	24
7.4	Akwizycja na ESP32	26
7.5	Wstępne wyniki pomiarowe	26
7.6	Ograniczenia toru HB100 i wnioski	26
8	Radar impulsowo-koherentny Acconeer A121	28
8.1	Charakterystyka czujnika	28
8.2	Konfiguracja pomiarowa	29
9	Inercyjne tory pomiarowe	30
9.1	Moduł LSM6DS3 z ESP32	30
9.2	Aplikacja iOS i transmisja BLE	31
9.3	Ograniczenie synchronizacji i kryteria oceny	32
10	Algorytmy estymacji oddechu i tętna	33
10.1	Model sygnału	33
10.2	Estymacja częstotliwości próbkowania	34
10.3	Usunięcie echa statycznego i wybór bramki odległościowej	35
10.4	Ekstrakcja fazy: dlaczego nie wprost $\arg z$	36
10.5	Estymacja częstości oddechu	37
10.6	Estymacja tętna — problem harmonicznym	37
10.7	Śledzenie tętna filtrem Kalmana (podgląd na żywo)	39
10.8	Miary pewności i bramki decyzyjne	40
10.9	Historia: co nie działało i dlaczego	40
10.10	Zestawienie parametrów	42
10.11	Oprogramowanie	42

11 Eksperyment: soczewki dielektryczne i wzmacnianie odbicia	43
11.1 Cel i hipotezy	43
11.2 Badane soczewki	43
11.3 Metodyka	45
11.4 Wyniki: porównanie soczewek	47
11.5 Wyniki: wpływ folii aluminiowej	50
11.6 Wnioski z eksperymentu	52
11.7 Retest folii i kąta padania na dystansie 2 m	53
11.7.1 Plan pomiaru	53
11.7.2 Rekonstrukcja sygnału i synchronizacja komend	53
11.7.3 Wyniki retestu	54
11.7.4 Wnioski z retestu	59
12 Sieci neuronowe do analizy faz oddechu	60
12.1 Sformułowanie zadania	60
12.2 Zbiór danych i anotacja	60
12.3 Architektura modelu	60
12.4 Uczenie i metryki	60
12.5 Wyniki	61
12.6 Dyskusja	61
III Część eksperymentalna: zastosowanie systemu	62
13 Całonocny monitoring snu	63
13.1 Cel badania	63
13.2 Metodyka pomiarów	63
13.3 Estymacja tętna i oddechu przez całą noc	65
13.4 Algorytm klasyfikacji faz snu	65
13.5 Ocena jakości snu (<i>sleep score</i>)	68
13.6 Wyniki: podsumowanie radarowe	72
13.7 Wyniki: porównanie tętna z Garmin Fenix 7	72
13.8 Wyniki: porównanie częstości oddechu	73
13.9 Wyniki: porównanie faz snu	73
13.10 Pułapka interpretacyjna: amplituda dominującego odbicia	78
13.11 Dyskusja wyników nocnych	79
14 Dalsze zastosowania i eksperymenty	80
14.1 Detekcja bezdechów	80
14.2 Pomiar na większych dystansach	80

14.3	Pomiar przez przeszkody	80
14.4	Wielu badanych i uogólnialność	81
14.5	Zastosowanie sieci neuronowych do klasyfikacji snu	81
15	Podsumowanie i wnioski końcowe	82
15.1	Kierunki dalszych prac	82

Spis rysunków

7.1	Schemat zaprojektowanego analogowego front-endu radaru HB100: dwa stopnie wzmacniające MCP6002 ($\approx 121\times$), filtracja pasmowa, wirtualna masa 1,65 V i separowane zasilanie analogowe MCP1700. . .	25
7.2	Prototyp toru pomiarowego HB100	25
9.1	Stanowisko pomiarowe z modułem LSM6DS3	31
10.1	Schemat potoku przetwarzania sygnału A121	34
11.1	Charakterystyki promieniowania badanych soczewek	44
11.2	Mocowanie radaru A121 na statywie	45
11.3	Profile amplitudy w funkcji odległości	47
11.4	Widma sygnału fazowego	49
11.5	Zestawienie metryk dla wszystkich nagrań	50
11.6	Parowane różnice dla folii aluminiowej	51
11.7	Przebiegi oddechowe	52
11.8	Przebiegi A121 przy 2 m z fazami komend	55
11.9	Profile i amplituda echa przy 2 m	56
11.10	Parowane efekty kąta i folii przy 2 m	57
11.11	Metryki sygnału oddechowego A121 przy 2 m	58
13.1	Stanowisko A121 nad łóżkiem	64
13.2	Fazy snu w pierwszych trzech nocach	75
13.3	Tętno w pierwszych trzech nocach	75
13.4	Częstość oddechu w pierwszych trzech nocach	76
13.5	Fazy snu z płaską pokrywą nad łóżkiem	76
13.6	Tętno z płaską pokrywą nad łóżkiem	77
13.7	Częstość oddechu z płaską pokrywą nad łóżkiem	77
13.8	Amplituda dominującego odbicia w trzech nocach	78

Spis tabel

3.1	Porównanie radarów HB100 i Acconeer A121 na podstawie dokumentacji producentów [17, 3, 5].	15
6.1	Etapy realizacji projektu na podstawie historii repozytorium.	22
7.1	Wybrane parametry modułu HB100 według noty katalogowej [17]. . .	24
10.1	Awarie algorytmu i ich rozwiązania	40
10.2	Ewolucja pasm filtrów	42
10.3	Parametry potoku przetwarzania	42
11.1	Uśrednione metryki dla każdej soczewki i odległości ($n=6$: oba stany folii $\times$ 3 powtórzenia).	48
11.2	Parowane różnice (folia — brak folii) dopasowane po soczewce, odległości i numerze powtórzenia (18 par, test Wilcoxona).	50
11.3	Mediany z trzech powtórzeń każdego warunku przy 2 m. σ_d jest odchyleniem standardowym położenia dominującego piku, A_{od} — połową zakresu między 5. i 95. percentylem ruchu w odcinkach sterowanych, a <i>hold</i> — $20 \log_{10}$ ilorazu RMS fazy oddechowej w środkowych 9 s wstrzymania i RMS podczas oddychania.	54
13.1	Składowe oceny jakości snu	70
13.2	Ocena snu i fazy: radar a dwa eksporty Garmina (noc 1)	71
13.3	Podsumowanie snu wyznaczone wyłącznie z radaru. Trzy ostatnie wiersze dotyczą pełnych nocy z płaską pokrywą i czujnikiem nad łóżkiem.	72
13.4	Porównanie tętna (okna snu): radar vs Garmin Fenix 7.	72
13.5	Porównanie częstości oddechu (okna snu): radar vs Garmin Fenix 7. . .	73
13.6	Summaryczny czas trwania faz snu. Różnica dodatnia oznacza, że radar przypisał danej fazie więcej czasu niż Garmin. Obie kolumny są estymatami — żadna z nich nie jest odniesieniem polisomnograficznym.	74
13.7	Amplituda dominującego odbicia a zgodność z celem.	78

Rozdział 1

Wstęp

1.1 Motywacja

Rytm oddechowy i tętno należą do podstawowych parametrów opisujących stan fizjologiczny człowieka. Ich długotrwała obserwacja jest istotna między innymi w medycynie snu, opiece domowej i monitorowaniu osób, dla których zakładanie klasycznych czujników może być uciążliwe. Pasy oddechowe, elektrody EKG i pulsoksymetry zapewniają bezpośredni związek z mierzoną wielkością, ale wymagają kontaktu z ciałem, właściwego założenia i tolerowania przewodów lub urządzenia nasobnego przez całą noc.

W pracy rozpatrzono dwie grupy metod mniej typowych. Pierwszą stanowią radary, które rejestrują ruch powierzchni ciała bez kontaktu i nie zależą od oświetlenia. Drugą są czujniki inercyjne: osobny moduł LSM6DS3 oraz sensory wbudowane w telefonie. IMU nie jest w tej pracy wzorcem dla radaru, lecz niezależnym, kontaktowym sposobem obserwowania kinematyki klatki piersiowej. Jego zaletą jest niski koszt i powszechna dostępność, szczególnie gdy akwizycję realizuje zwykły smartfon. Badanie obejmuje zatem nie tylko dokładność estymowanej częstości, ale również praktyczną użyteczność sygnału w różnych pozycjach ciała.

Zestawienie prostego radaru CW HB100 z koherentnym radarem impulsowym A121 pozwala pokazać, jak dostęp do odległości oraz zespolonych danych I/Q zmienia możliwości analizy. Uzupełnieniem jest ocena wpływu soczewek, folii aluminiowej, odzieży i innych materiałów znajdujących się między radarem a badanym.

1.2 Cel i zakres pracy

Celem głównym pracy jest zaprojektowanie i ocena systemu do rejestracji oraz analizy sygnałów związanych z oddechem i pracą serca z wykorzystaniem niekonwencjonalnych torów pomiarowych. Zakres obejmuje:

1. budowę toru radaru dopplerowskiego HB100 wraz z analogowym układem kondycjonowania i akwizycją na ESP32,
2. integrację radaru Acconeer A121 oraz analizę surowych danych Sparse IQ,
3. opracowanie algorytmów estymacji częstości oddechu i tętna,
4. uruchomienie osobnych torów inercyjnych: LSM6DS3 oraz aplikacji iOS wykorzystującej Core Motion i transmisję BLE,
5. eksperymentalną ocenę wpływu odległości, soczewki, folii aluminiowej, materiałów pośrednich i pozycji badanego na użyteczność sygnału,
6. przygotowanie danych i metod bazowych do oceny możliwości zastosowania sieci neuronowych w analizie faz cyklu oddechowego.

Ostateczny zakres części dotyczącej sieci neuronowych zostanie doprecyzowany po ocenie jakości i liczności zgromadzonego zbioru danych; nie wpływa to na zakres zbudowanego systemu pomiarowego i badań sygnałowych.

1.3 Struktura pracy

Praca dzieli się na trzy części:

- **Część I** — przegląd literatury i istniejących rozwiązań bezkontaktowego pomiaru parametrów vitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem architektur radarowych.
- **Część II** — opis zbudowanego systemu: tor radaru HB100 z autorskim front-endem analogowym, integracja radaru Acconeer A121, algorytmy estymacji oddechu i tętna, oprogramowanie oraz eksperyment porównujący soczewki i wzmacnianie odbicia folią aluminiową.
- **Część III** — zastosowanie systemu: całonocne pomiary snu, porównanie z zegarkiem Garmin Fenix 7 oraz algorytmy klasyfikacji faz snu.

Część I

Przegląd literatury i istniejących rozwiązań

Rozdział 2

Bezkontaktowy pomiar parametrów vitalnych

2.1 Mierzone parametry i ich zakresy fizjologiczne

W potoku przetwarzania przyjęto pasmo oddechowe 0,10 Hz do 0,50 Hz, odpowiadające 6–30 oddechom na minutę, oraz pasmo sercowe 0,70 Hz do 2,00 Hz, czyli 42–120 uderzeniom na minutę. Oddychanie powoduje ruch powierzchni tułowia rzędu milimetrów, natomiast drgania wywołane pracą serca są znacznie słabsze. Oba zjawiska mogą więc pojawić się w sygnale ruchowym, ale ich separacja wymaga innych filtrów i miar jakości.

Żaden z zastosowanych czujników nie mierzy bezpośrednio objętości oddechowej ani czynności elektrycznej serca. Radar obserwuje zmianę odległości radialnej i fazy odbicia, akcelerometr — przyspieszenie właściwe, a żyroskop — prędkość kątową obudowy. Częstość oddechu i tętno są wielkościami wyznaczanymi pośrednio z okresowości tych sygnałów. Z tego powodu wyniki należy interpretować jako ocenę użyteczności metod ruchowych, a nie jako walidację kliniczną.

2.2 Motywacja kliniczna

Miejsce zarezerwowane: Polisomnografia jako złoty standard i jej ograniczenia. Monitoring domowy, opieka senioralna, zespół nagłej śmierci łóżeczkowej.

2.3 Klasyczne metody kontaktowe

Do metod klinicznych i laboratoryjnych należą między innymi EKG, pulsoksymetria, spirometria oraz pasy do pletyzmografii indukcyjnej (RIP). Mierzą one inne wielkości fizyczne niż radar i IMU, dlatego mogą pełnić rolę zewnętrznego odniesienia,

lecz nie są wymienne z pomiarem ruchu powierzchni ciała. W niniejszym projekcie dane z zegarka Garmin wykorzystano jedynie jako porównanie konsumenckie dla pomiarów nocnych. LSM6DS3 i iPhone są natomiast pełnoprawnymi, osobnymi torami badanymi pod kątem wykrywalności oddechu i tętna.

Rozdział 3

Radarowe metody pomiaru parametrów witalnych

3.1 Radary dopplerowskie fali ciągłej (CW)

Radary CW nadają sinusoidę o stałej częstotliwości. Ruch celu zmienia fazę sygnału odbitego, a ruch ze stałą prędkością powoduje przesunięcie Dopplera $f_d = 2v/\lambda$. Dla ruchu okresowego, takiego jak oddychanie, wyjście mieszacza jest modulowane zmianą odległości powierzchni klatki piersiowej. Układ jest prosty i tani, ale sygnały od wszystkich obiektów w wiązce sumują się w jednym kanale — nie ma informacji, z jakiej odległości pochodzi dany składnik.

W odbiorniku jednokanałowym napięcie ma w uproszczeniu postać

$$b(t) = A \cos\left(\frac{4\pi}{\lambda}[d_0 + x(t)] + \varphi_0\right). \quad (3.1)$$

Dla małego ruchu czułość zależy od fazy statycznej celu. W pewnych odległościach pochodna funkcji cosinus zanika i powstają punkty zerowe (*null points*). Drugi, przesunięty o 90° kanał kwadraturowy Q uzupełnia kanał I i pozwala śledzić fazę niezależnie od tego położenia. Niskokosztowy HB100 udostępnia jednak tylko pojedyncze, rzeczywiste wyjście IF, co stanowi jego fundamentalne ograniczenie [17].

3.2 Radary FMCW

Radary FMCW nadają ciąg odcinków, w których częstotliwość nośna zmienia się liniowo w czasie (*chirp*). Po zmieszaniu echa z sygnałem nadawanym częstotliwość różnicowa jest proporcjonalna do opóźnienia, a więc do odległości celu. FFT próbek pojedynczego chirpu tworzy profil odległości, natomiast analiza faz kolejnych chirpów pozwala oszacować prędkość radialną. W radarach wielokanałowych dodatkowa

analiza różnic faz między antenami dostarcza kąta nadejścia. Cena za rozdzielczość odległościową to większa złożoność toru RF, akwizycji i obliczeń [7].

3.3 Radary impulsowo-koherentne (PCR)

Radary impulsowo-koherentne wysyła krótkie impulsy i próbkują echo w wybranych opóźnieniach odpowiadających odległościom. Zachowanie koherencji pomiędzy pomiarami umożliwia zwracanie zespolonych próbek I/Q. A121 pracuje w paśmie 57 GHz do 64 GHz; przy długości fali około 5 mm pełny obrót fazy odpowiada zmianie drogi w obie strony, czyli radialnemu przesunięciu celu o około 2,5 mm [3, 4].

A121 nie jest radarem FMCW i nie wyznacza odległości z częstotliwości dudnień chirpu. Zarówno FMCW, jak i PCR mogą wytworzyć profil celu względem odległości, lecz robią to inną metodą: FMCW koduje opóźnienie w częstotliwości sygnału IF, a PCR próbkują odpowiedź na koherentny impuls. W projekcie wykorzystywana jest usługa Sparse IQ: dla każdego punktu odległości zapisuje się amplitudę oraz fazę odbicia.

3.4 Radary UWB

Miejsce zarezerwowane: Ultra-wideband w monitoringu oddechu, rozdzielczość czasowa, przegląd literatury.

3.5 Porównanie torów HB100 i A121

Tabela 3.1 zestawia cechy istotne w tej pracy. Nie jest to porównanie dwóch równoważnych czujników: HB100 udostępnia minimalny tor dopplerowski wymagający własnej elektroniki analogowej, natomiast A121 jest zintegrowanym radarem koherentnym z cyfrowym profilem odległości.

Tabela 3.1: Porównanie radarów HB100 i Acconeer A121 na podstawie dokumentacji producentów [17, 3, 5].

Cecha	HB100	Acconeer A121 / moduł Wave-share
Pasmo pracy	10,525 GHz, $\lambda \approx 28,5$ mm	57 GHz do 64 GHz, $\lambda \approx 5$ mm
Rodzaj radaru	bistatyczny CW Doppler	impulsowo-koherentny PCR
Dane wyjściowe	jeden rzeczywisty sygnał analogowy IF	zespolone Sparse IQ dla wielu punktów odległości
Rozdzielenie celów po odległości	brak	tak, zależne od profilu impulsu
Mikroruch	zmiana napięcia zależna od fazy celu; punkty zerowe	zmiana fazy I/Q w wybranej bramce odległościowej
Typowy EIRP	15 dBm	11,4 dBm
Szerokość wiązki bez dodatkowej soczewki	80° w azymucie, 40° w elewacji	typowo 53° w płaszczyźnie E, 65° w płaszczyźnie H
Elektronika zewnętrzna	wzmacniacz, filtr, ADC i mikrokontroler	układ RF, baseband i anteny w obudowie; moduł zawiera STM32 i USB/UART
Najważniejsze ograniczenie w projekcie	brak odległości i kwadratury, wrażliwość na całe otoczenie	większa złożoność konfiguracji, przeciek bezpośredni, dobór profilu i bramki celu

3.6 Odbicie, transmisja i tłumienie w materiałach

Fala padająca na granicę materiałów dzieli się na część odbitą, transmitowaną i pochłoniętą. Proporcje zależą od zespolonej przenikalności elektrycznej, przewodności, grubości, częstotliwości, polaryzacji i kąta padania. Dlatego potoczne stwierdzenie, że radar „widzi przez materiał”, jest nieprecyzyjne: część energii może przejść przez przeszkodę, lecz po przejściu w obie strony i odbiciu od klatki sygnał może już znaleźć się poniżej użytecznego poziomu. Warstwowa budowa materiału może ponadto powodować interferencję i zmieniać fazę echa.

Różnica częstotliwości pomiędzy zastosowanymi radarami jest duża. Dla HB100 długość fali wynosi około 28,5 mm, a dla A121 około 5 mm. Przy krótszej fali większego znaczenia nabierają niewielkie nierówności powierzchni, grubość warstw i dokładne ustawienie. Pomiarów materiałów budowlanych w zakresie 4 GHz do 40 GHz wykazały dla wielu lekkich materiałów wewnętrznych jedynie umiarkowaną stratę, podczas gdy pustaki powodowały straty większe o dziesiątki decybeli [8]. W badaniach budynków przy 60 GHz zmierzono zależne od kąta i konstrukcji straty rzędu

12–32 dB dla ściany gipsowej, 8–18 dB dla szkła wewnętrznego i 26–41 dB dla drewnianych drzwi [9]. Liczby te nie są stałymi materiałowymi — obejmują konkretne grubości, warstwy i geometrię pomiaru — ale pokazują, dlaczego wyników dla 10,525 GHz nie można bezpośrednio przenosić na 60 GHz.

W scenariuszu monitoringu snu szczególnie istotne są odzież i pościel. Eksperyment z modulowanym reflektorem przy 61, 122 i 175 GHz wykazał, że cienkie suche tkaniny wnoszą niewielką stratę, natomiast zawilgocenie może znacznie zwiększyć tłumienie [10]. Uzasadnia to osobny test przez suchą kołdrę, ale również wymaga zapisania rodzaju i stanu materiału.

Metal zachowuje się odmiennie od dielektryków. Dla dobrego przewodnika energia wnika jedynie na głębokość naskórkową

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}. \quad (3.2)$$

Dla aluminium otrzymuje się w przybliżeniu 0,83 μm przy 10,525 GHz i 0,35 μm przy 60 GHz, znacznie mniej niż grubość folii kuchennej. Folia jest więc praktycznie nieprzezroczystym reflektorem dla obu radarów. Nie oznacza to jednak automatycznej poprawy pomiaru: niewielka łata konkuruje z odbiciem od całego, bogatego w wodę tułowia, a zmiana dominującego reflektora może jednocześnie zmienić amplitudę, fazę i wielodrogowość.

3.7 Soczewki dielektryczne i kształtowanie wiązki

Miejsce zarezerwowane: Soczewki refrakcyjne (hiperboliczna, plano-convex) i dyfrakcyjne (płytki strefowa Fresnela, FZP). Zysk anteny a szerokość wiązki, kompromis zysk/pole widzenia. Materiał teoretyczny do wykorzystania w rozdziale 11.

Rozdział 4

Metody niradarowe

4.1 Czujniki inercyjne (IMU)

Czujnik inercyjny umieszczony na tułowi rejestruje zmianę orientacji i ruch wywołany oddechem. Składowe o wyższej częstotliwości mogą zawierać drgania sejsmokardiograficzne (SCG) i gyro-kardiograficzne (GCG) związane z pracą serca. Jest to metoda kontaktowa, lecz nie wymaga specjalizowanego pasa oddechowego: odpowiednie sensory znajdują się również w telefonach.

Landreani i wsp. rejestrowali oddech dwoma telefonami ułożonymi na mostku i nadbrzuszu osób leżących, stosując kontrolowane częstotliwości 0,10 Hz do 0,25 Hz; po filtracji uzyskali błąd częstości poniżej 2% względem pasa, z lepszymi wynikami nad brzuchem [11]. Nayak i Bolic pokazali możliwość jednoczesnej estymacji oddechu i tętna z IMU telefonu swobodnie leżącego na klatce w pozycji na plecach [12]. Wyniki literaturowe uzasadniają sprawdzenie własnej aplikacji iOS zarówno w leżeniu, jak i w pozycji siedzącej, ale nie zastępują oceny konkretnego telefonu, sposobu mocowania i implementacji transmisji BLE.

W projekcie zrealizowano dwa niezależne warianty: moduł LSM6DS3 odczytywany przez ESP32 oraz aplikację iOS korzystającą z Core Motion. Oba zapisują trzy osie akcelerometru i żyroskopu do wspólnego formatu CSV, dzięki czemu można porównać jakość przebiegu, stabilność częstości próbkowania i wrażliwość na pozycję ciała. Ich rola i implementacja zostały opisane w rozdziale 9.

4.2 Metody optyczne

Miejsce zarezerwowane: rPPG z kamery RGB, termowizja, kamery głębi.

4.3 Urządzenia nasobne jako źródło porównania

Miejsce zarezerwowane: Zegarki sportowe, w tym Garmin Fenix 7 wykorzystany jako konsumenckie źródło porównania w części III. Dokładność szacowania faz snu przez zegarki względem polisomnografii.

4.4 Rozwiązania komercyjne

Miejsce zarezerwowane: Google Nest Hub (radar Soli), Withings Sleep Analyzer, Somnofy.

Rozdział 5

Uczenie maszynowe w analizie sygnałów oddechowych

5.1 Klasyczne podejścia oparte na cechach

Miejsce zarezerwowane: FFT/Welch, filtracja pasmowa, detekcja pików — czyli to, co zaimplementowano jako baseline w rozdziale 10.

5.2 Sieci neuronowe dla sygnałów jednowymiarowych

Miejsce zarezerwowane: 1D-CNN, LSTM/GRU, architektury typu transformer dla szeregów czasowych; uczenie na spektrogramach.

5.3 Klasyfikacja faz oddechu

Miejsce zarezerwowane: Detekcja wdechu, wydechu i pauzy oddechowej — przegląd metod. To jest bezpośrednia podstawa teoretyczna dla rozdziału 12.

5.4 Dostępne zbiory danych

Miejsce zarezerwowane: Publiczne zbiory radarowych sygnałów vitalnych; problem braku etykiet faz oddechu i konieczność samodzielnej anotacji.

Część II

Zbudowany system pomiarowy

Rozdział 6

Architektura systemu i przebieg prac

6.1 Ogólna architektura

System składa się z czterech torów pomiarowych zintegrowanych w jednej aplikacji desktopowej:

1. radar dopplerowski HB100 z analogowym front-endem i akwizycją przez przetwornik ADC mikrokontrolera ESP32,
2. radar impulsowo-koherentny Acconeer A121 podłączony przez USB-UART, dostarczający surowe dane Sparse IQ,
3. czujnik inercyjny LSM6DS3 na ESP32 (osobna metoda kontaktowa),
4. aplikacja na iPhone strumieniująca dane z CoreMotion przez BLE (drugi wariant metody inercyjnej).

Wspólna warstwa programowa zapewnia nagrywanie do plików CSV oraz bazy SQLite, podgląd na żywo i analizę offline.

Miejsce zarezerwowane: Rysunek blokowy całego systemu (do wykonania). Powinien pokazywać przepływ: czujnik → kondycjonowanie → akwizycja → zapis → analiza → wynik.

6.2 Przebieg prac i ewolucja projektu

Projekt rozwijał się iteracyjnie; historia repozytorium dokumentuje kolejne etapy oraz zmiany kierunku, które okazały się kluczowe dla ostatecznego kształtu pracy.

Tabela 6.1: Etapy realizacji projektu na podstawie historii repozytorium.

Okres	Etap	Zakres prac
III 2026	Start	Pierwsza akwizycja, uruchomienie toru radarowego HB100, podstawowe wykresy i FFT.
IV–V 2026	Tor IMU	Akwizycja I2C z LSM6DS3, analiza PCA, filtry Butterwortha; wyodrębnienie rytmu oddechu i tętna.
18 V 2026	<i>Zmiana kierunku</i>	Przeniesienie głównego nacisku z czujnika IMU na tor radarowy.
31 V 2026	Integracja A121	Wsparcie dla radaru Acconeer A121, schemat front-endu analogowego, prototyp aplikacji.
1 VI 2026	Parametry vitalne	Poprawki algorytmu estymacji oddechu i tętna (bramkowanie odległościowe, miary pewności).
VI 2026	Eksperymenty	Pomiary całonocne, aplikacja na iPhone, rozbudowa bazy nagrań.
VII 2026	Eksperyment sterowany	Automatyczna procedura badania soczewek i folii aluminiowej (36 nagrań, 12 warunków, 3 powtórzenia).

Zmiana głównego kierunku z IMU na radar wynikała z odmiennego scenariusza użytkowego: czujnik inercyjny musi poruszać się wraz z ciałem, natomiast radar umożliwia obserwację z odległości. Nie oznacza to odrzucenia IMU ani nadania mu roli wzorca. W dalszej części oba warianty inercyjne są oceniane jako osobne, niekonwencjonalne metody pomiaru. W torach radarowych głównymi problemami były niska amplituda analogowego wyjścia HB100, punkty zerowe odbiornika jednokanałowego oraz wybór właściwego odbicia w danych odległościowych A121.

Rozdział 7

Radar dopplerowski HB100

7.1 Moduł HB100 — zasada działania

Moduł HB100 to niskokosztowy, bistatyczny radar dopplerowski fali ciągłej pracujący nominalnie przy 10,525 GHz. Odbity sygnał jest mieszany z sygnałem nadawanym, a na wyjściu pośredniej częstotliwości (IF) pojawia się składowa zależna od ruchu radialnego celu. Dla stałej prędkości v przesunięcie Dopplera wynosi

$$f_d = \frac{2v}{\lambda} = \frac{2vf_0}{c}. \quad (7.1)$$

Oddech jest jednak ruchem okresowym, a nie ruchem ze stałą prędkością. Jego przemieszczenie $x(t)$ zmienia fazę echa o $4\pi x(t)/\lambda$, zgodnie z modelem (3.1). Przy $\lambda \approx 28,5$ mm pełny obrót fazy odpowiada przesunięciu celu o około 14,2 mm. Ponieważ HB100 udostępnia tylko jeden rzeczywisty kanał IF, lokalna czułość na mały ruch jest proporcjonalna do sinusa fazy statycznej. Zmiana średniej odległości o około $\lambda/4 \approx 7,1$ mm może zatem przenieść układ z maksimum czułości do punktu zerowego. W pobliżu takiego punktu składowa podstawowa oddechu słabnie, a względnie rośnie druga harmoniczna. Nie jest to błąd filtracji, lecz konsekwencja jednokanałowej architektury CW.

Tabela 7.1: Wybrane parametry modułu HB100 według noty katalogowej [17].

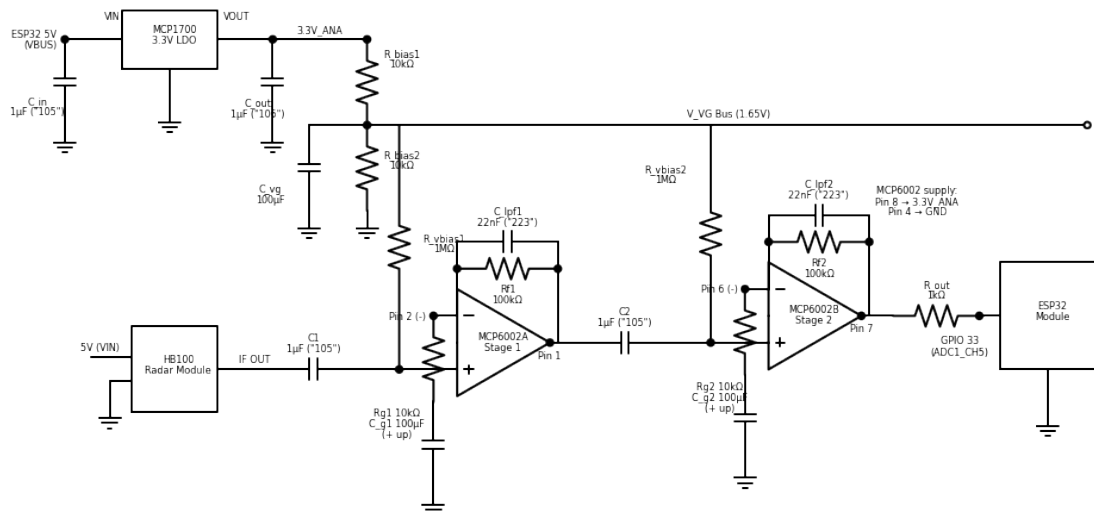
Parametr	Wartość
Częstotliwość nadawcza	10,520 GHz do 10,530 GHz, typowo 10,525 GHz
EIRP	12 dBm do 20 dBm, typowo 15 dBm
Sygnał IF w warunkach pomiarowych producenta	typowo 200 μ V p-p przy dwukierunkowej stracie toru 93 dB
Szum wyjścia IF	typowo 5 μ V RMS w paśmie 10 Hz do 100 Hz
Szerokość wiązki	typowo 80° w azymucie i 40° w elewacji
Zasilanie	5 V, pobór prądu 30 mA do 40 mA

7.2 Problem: amplituda sygnału wyjściowego

Podstawowym problemem praktycznym okazała się bardzo niska amplituda sygnału IF — rzędu pojedynczych miliwoltów — niemożliwa do bezpośredniego pomiaru przetwornikiem ADC mikrokontrolera ESP32. Wymusiło to zaprojektowanie dedykowanego analogowego układu kondycjonowania sygnału.

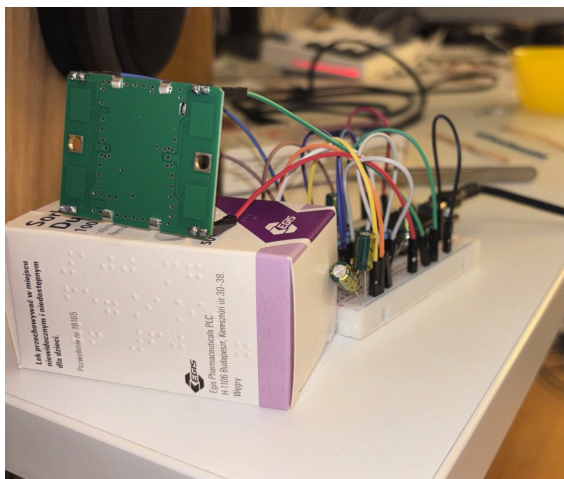
7.3 Zaprojektowany analogowy front-end

Zbudowany układ (rys. 7.1) opiera się na dwóch symetrycznych stopniach nieodwracających na wzmacniaczu operacyjnym MCP6002. Każdy stopień wykorzystuje $R_f = 100\text{ k}\Omega$ oraz $R_g = 10\text{ k}\Omega$, co daje wzmocnienie około $11\times$ na stopień i w przybliżeniu $121\times$ łącznie. Kondensator 22 nF w pętli sprzężenia zwrotnego ogranicza pasmo od góry. Wejścia sprzężone pojemnościowo są podciągane do wirtualnej masy 1,65 V rezystorami 1 M Ω , a wyjście zabezpieczono rezystorem 1 k Ω przed wejściem ADC (GPIO 33 / ADC1_CH5). Zasilanie części analogowej realizuje stabilizator liniowy MCP1700, aby odseparować ją od zakłóceń cyfrowych ESP32.

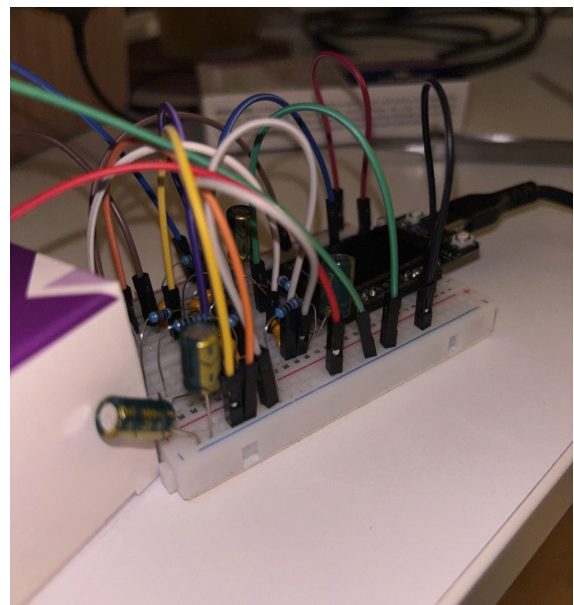


Rysunek 7.1: Schemat zaprojektowanego analogowego front-endu radaru HB100: dwa stopnie wzmacniające MCP6002 ($\approx 121\times$), filtracja pasmowa, wirtualna masa 1,65 V i separowane zasilanie analogowe MCP1700.

Wykonany prototyp przedstawiono na rys. 7.2. Moduł HB100, analogowy układ kondycjonowania oraz ESP32 połączono na płytce stykowej. Taka postać stanowiska ułatwiała zmianę elementów podczas uruchamiania toru, ale wymagała zachowania stałego prowadzenia przewodów ze względu na podatność wejścia o małej amplitudzie na zakłócenia.



(a) Moduł HB100 oraz układ kondycjonowania i akwizycji.



(b) Zbliżenie analogowego front-endu na płytce stykowej.

Rysunek 7.2: Prototyp toru pomiarowego HB100 z dwustopniowym front-endem i mikrokontrolerem ESP32 (fotografie własne).

Miejsce zarezerwowane: Do uzupełnienia: obliczenia projektowe (dobór częstotliwości granicznych filtru pod pasmo oddechu 0,1–0,5 Hz i tętna 0,7–2,0 Hz), charakterystyka częstotliwościowa układu (symulacja i pomiar), analiza szumów oraz pomiary oscyloskopem.

7.4 Akwizycja na ESP32

Firmware w katalogu `firmware/esp32_radar_adc` korzysta z wejścia GPIO 33 (ADC1, kanał 5) z tłumieniem `ADC_ATTEN_DB_12`. Każda publikowana próbka jest średnią z 64 kolejnych konwersji ADC. Napięcie jest przeliczane z wykorzystaniem kalibracji liniowej ESP-IDF, a w razie jej braku stosowane jest przeliczenie przybliżone. Zadany okres transmisji wynosi 2 ms, czyli nominalnie 500 Hz; jest to duży nadmiar względem pasm oddechu i tętna, ale ułatwia późniejsze filtrowanie i ocenę szumu toru.

Każdy wiersz transmisji przy 921 600 baud zawiera znacznik czasu z zegara `esp_timer` w milisekundach, uśredniony kod ADC oraz napięcie w mV. Na komputerze dane otrzymują nagłówek `Timestamp_ms,RawADC,Voltage_mV`. O rzeczywistej częstotliwości próbkowania nie należy jednak wnioskować wyłącznie z wartości zadanej: średni czas 64 konwersji, formatowanie tekstu i transmisja mogą powodować jitter. Dlatego jest ona wyznaczana z różnic znaczników czasu, a przed każdym eksperymentem należy sprawdzić monotoniczność czasu, liczbę brakujących próbek oraz rozkład odstępów.

7.5 Wstępne wyniki pomiarowe

Wstępne pomiary potwierdziły możliwość detekcji oddechu z odległości około 50 cm od klatki piersiowej. Zaobserwowano również, że wstrzymanie oddechu odsłania w sygnale oscylacje odpowiadające pracy serca.

Do domknięcia oceny toru potrzebne są: wykresy czasowe i widma Welcha dla powtarzalnej serii, odsetek nagrań z pikiem przy częstotliwości narzuconej metronomem oraz przypadki niepowodzenia (ruch tła, punkt zerowy, druga harmoniczna). Jednoczesne nagranie HB100 i A121 może służyć porównaniu dwóch metod obserwujących ten sam oddech, ale A121 nie jest przez to wzorcem prawdy. Kontrolę negatywną stanowią odcinki bez ruchu badanego i ze wstrzymanym oddechem.

7.6 Ograniczenia toru HB100 i wnioski

HB100 sumuje echa ze wszystkich obiektów w wiązce, nie rozdziela ich po odległości i nie udostępnia kanału kwadraturowego. Wynik zależy więc od statycznej fazy celu,

ruchu tła i wielodrogowości. Te ograniczenia wyjaśniają, dlaczego nawet duże wzmocnienie analogowe nie gwarantuje powtarzalnego pomiaru mikroruchu. Wprowadzenie A121 nie było wyłącznie wymianą czujnika na czulszy, lecz zmianą klasy pomiaru: możliwy stał się wybór bramki odległościowej i praca na pełnym sygnale I/Q. HB100 pozostaje samodzielną niskokosztową metodą oraz demonstracją kompletnego łańcucha inżynierskiego — od mikrofalowego modułu i analogowego kondycjonowania po cyfrową estymację rytmu oddechowego. Jego praktycznym wynikiem powinno być wskazanie granic użyteczności, a nie próba uznania go za referencję dla A121.

Rozdział 8

Radar impulsowo-koherentny Acconeer A121

8.1 Charakterystyka czujnika

Acconeer A121 to radar impulsowo-koherentny pracujący w paśmie 57 GHz do 64 GHz [3]. W przeciwieństwie do HB100 dostarcza on zespolone dane Sparse IQ dla całego szeregu bramek odległościowych, co pozwala jednocześnie *zlokalizować* cel i śledzić *fazę* sygnału od niego odbitego. Przy długości fali $\lambda \approx 5$ mm przesunięcie fazy $\Delta\varphi$ odpowiada przemieszczeniu celu

$$\Delta d = \frac{\lambda}{4\pi} \Delta\varphi, \quad (8.1)$$

co daje czułość rzędu ułamków milimetra — wystarczającą, aby zarejestrować zarówno oddech (kilka milimetrów), jak i składową sercową.

Sam układ A121 integruje część radiową, baseband oraz anteny w obudowie o wymiarach około $5,2 \times 5,5 \times 0,88$ mm. Producent podaje EIRP 11,4 dBm, typowe szerokości wiązki 53° i 65° w dwóch płaszczyznach oraz możliwość bezwzględnego pomiaru odległości do 23 m, zależną od celu i konfiguracji [3]. Ostatnia wartość nie jest zasięgiem detekcji oddechu; mikroruch klatki stanowi znacznie trudniejszy cel i musi zostać scharakteryzowany eksperymentalnie.

W projekcie użyto płytki Waveshare A121 Range Sensor z mikrokontrolerem STM32L431, interfejsem USB/UART oraz zasilaniem 5 V. Moduł ma wymiary 39×39 mm i według producenta pobiera maksymalnie 80 mA [5]. Rozdzielczości profilu odległościowego nie należy mylić z czułością fazową: dla profilu 3 szerokość odpowiedzi impulsowej jest rzędu 89 mm, lecz po ustabilizowaniu właściwej bramki względną zmianę drogi można śledzić znacznie dokładniej na podstawie fazy.

8.2 Konfiguracja pomiarowa

W pomiarach wykorzystano konfigurację: profil 3, HWAAS 32, 8 przemiatkań na ramkę, częstotliwość ramek 20 Hz, zakres 0,20 m do 1,50 m. Dane zapisywane są do plików CSV zawierających m.in. składowe rzeczywistą i urojoną dla każdej bramki odległościowej, amplitudę, fazę oraz metadane z wbudowanych detektorów Acconeera.

Profil 3 stanowi kompromis między energią impulsu, separacją celów i zasięgiem. Parametr HWAAS określa liczbę sprzętowo uśrednianych próbek: jego zwiększenie poprawia SNR kosztem czasu pomiaru i zużycia energii. Osiem przemiatkań jest uśrednianych w ramce, natomiast 20 Hz zachowuje duży zapas względem pasma oddechu oraz pasma sercowego używanego w projekcie. Dla każdego dystansu trzeba rozszerzyć konfigurowany przedział tak, aby obejmował cel; w przeciwnym razie eksperyment mierzy ograniczenie konfiguracji, a nie radaru. Komputer łączy się z czujnikiem przez klienta szeregowego Acconeer Exploration Tool. Z każdej ramki zapisywane są odległości oraz tablice wartości rzeczywistych i urojonych, co umożliwia ponowne wykonanie całej analizy offline.

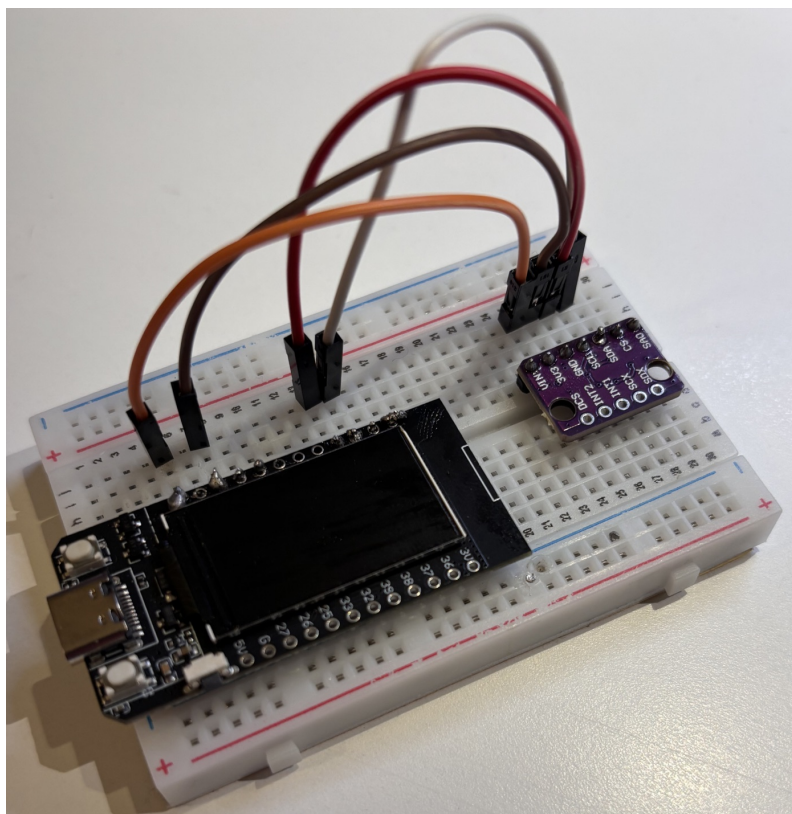
Rozdział 9

Inercyjne tory pomiarowe

Czujniki inercyjne tworzą w tej pracy osobny nurt pomiarowy. Rejestrują ruch obudowy spoczywającej na tułowiu, podczas gdy radar rejestruje zmianę drogi propagacji fali. Zgodność częstości wyznaczonej z obu metod może być użyteczną kontrolą spójności, ale sama nie czyni IMU wzorcem dla radaru. Ocena dotyczy tego, czy sygnał inercyjny jest dostatecznie czytelny w pozycji siedzącej i leżącej oraz czy prosty tor z telefonem może zastąpić osobny moduł sprzętowy.

9.1 Moduł LSM6DS3 z ESP32

LSM6DS3 zawiera trójosiowy akcelerometr i trójosiowy żyroskop. Wykorzystany firmware ESP-IDF komunikuje się z czujnikiem po I2C z częstotliwością 400 kHz. Rejestry CTRL1_XL oraz CTRL2_G otrzymują wartość 0x70, co ustawia częstotliwość ODR obu sensorów na 1,66 kHz, zakres akcelerometru $\pm 2g$ i żyroskopu $\pm 250^\circ \text{s}^{-1}$ [13]. Po zgłoszeniu gotowości obu części odczytywane są trzy osie przyspieszenia w g oraz trzy osie prędkości kątowej w stopniach na sekundę i wysyłane tekstowo przez UART.



Rysunek 9.1: Moduł LSM6DS3 połączony przez I2C z mikrokontrolerem ESP32 na prototypowej płytce stykowej (fotografia własna).

Analiza offline filtruje trzy osie w paśmie oddechowym 0,10 Hz do 0,60 Hz, a następnie wyznacza pierwszą składową główną PCA. Osobna ścieżka łączy żyroskop z kierunkiem grawitacji filtrem komplementarnym i tworzy sygnał kąta oddechowego. Składowa sercowa jest poszukiwana w paśmie 0,65 Hz do 4,00 Hz. PCA redukuje zależność od wyboru pojedynczej osi, ale nie gwarantuje niezmienności względem postawy, miejsca położenia czujnika ani przesunięcia podczas pomiaru. To założenie wymaga sprawdzenia osobno dla pozycji siedzącej i leżącej.

9.2 Aplikacja iOS i transmisja BLE

Aplikacja *RespiPhoneIMU* korzysta z `CMDeviceMotion`. Użytkownik wybiera 25 Hz, 50 Hz albo 100 Hz; domyślnie ustawiono 100 Hz. Zapisywane przyspieszenie jest sumą wektora grawitacji i `userAcceleration`, natomiast prędkość kątowna pochodzi z estymaty `rotationRate` dostarczanej przez Core Motion [14]. Każda próbka otrzymuje znacznik `motion.timestamp` względem początku strumienia. Jest to istotne, ponieważ Apple zaleca wyznaczanie rzeczywistych odstępów aktualizacji właśnie ze znaczników czasu, a nie z samej zadanej wartości interwału [15].

Telefon działa jako urządzenie peryferyjne BLE. W jednym powiadomieniu może przesłać kilka próbek; każda zawiera własny czas, sześć składowych ruchu,

a nagłówek paczki — numer sekwencyjny. Komputer wyrównuje pierwszy czas telefonu do zegara hosta i zapisuje ten sam schemat CSV co dla LSM6DS3: `Time_ms,ax,ay,az,gx,gy,gz`. Grupowanie próbek w paczki nie zniekształca więc osi czasu, o ile zachowane są czasy próbek. Numer sekwencyjny umożliwia wykrywanie zagubionych powiadomień po dodaniu kontroli jego ciągłości po stronie odbiornika.

9.3 Ograniczenie synchronizacji i kryteria oceny

W obecnej wersji firmware LSM6DS3 wysyła jedynie sześć wartości pomiarowych, bez znacznika czasu ani licznika próbki. Aplikacja desktopowa nadaje im czas dopiero podczas przetwarzania kolejnych wierszy UART. Buforowanie transmisji może wtedy utworzyć wiele próbek o niemal identycznym czasie i zafałszować oszacowanie częstotliwości próbkowania. Przed ilościową oceną LSM6DS3 należy dodać czas z `esp_timer` lub monotonny licznik próbek do firmware i obsłużyć go po stronie komputera. iPhone ma już czas per próbka, lecz nadal trzeba sprawdzić histogram Δt , luki numerów sekwencyjnych i rzeczywistą liczbę próbek na sekundę.

Podstawowy eksperyment obejmuje dla obu urządzeń pozycję siedzącą i leżącą, oddech swobodny, oddech narzucony metronomem oraz krótki odcinek wstrzymania oddechu. Porównywane powinny być: dominująca częstotliwość, SNR widmowy, prominenca piku, stabilność wyniku w kolejnych oknach oraz udział wariancji wyjaśniony przez PCA. Wniosek ma dotyczyć użyteczności każdego toru, nie jego zgodności z rzekomym wzorcem radarowym.

Rozdział 10

Algorytmy estymacji oddechu i tętna

Rozdział ten opisuje najobszerniejszą część własnej pracy programistycznej: potok przetwarzania, który z surowych danych Sparse IQ czujnika A121 wyznacza częstość oddechu i tętno. Implementacja liczy około 2300 linii (`src/respi_net/a121_vitals.py`) i składa się z dwóch ścieżek:

- `analize_a121_vitals()` — bezstanowy analizator okna, używany do analizy nagrań CSV i historii; to on dostarcza wszystkich liczb prezentowanych w tej pracy,
- `A121LiveTraceProcessor` — stanowy procesor strumieniowy z pamięcią filtrów IIR, używany wyłącznie do rysowania przebiegów na żywo, tak aby raz narysowana próbka nie zmieniała już kształtu przy kolejnym odświeżeniu wykresu.

Świadomie opisano tu również *drogę dojścia* do obecnej postaci algorytmu. Pierwsza wersja, mimo poprawnej teorii, dawała wyniki bezużyteczne; sekcja 10.9 zestawia kolejne awarie, ich przyczyny i zastosowane rozwiązania.

10.1 Model sygnału

Czujnik zwraca dla każdej ramki n i bramki odległościowej k liczbę zespoloną

$$z[n, k] = A[n, k] e^{j\varphi[n, k]}, \quad (10.1)$$

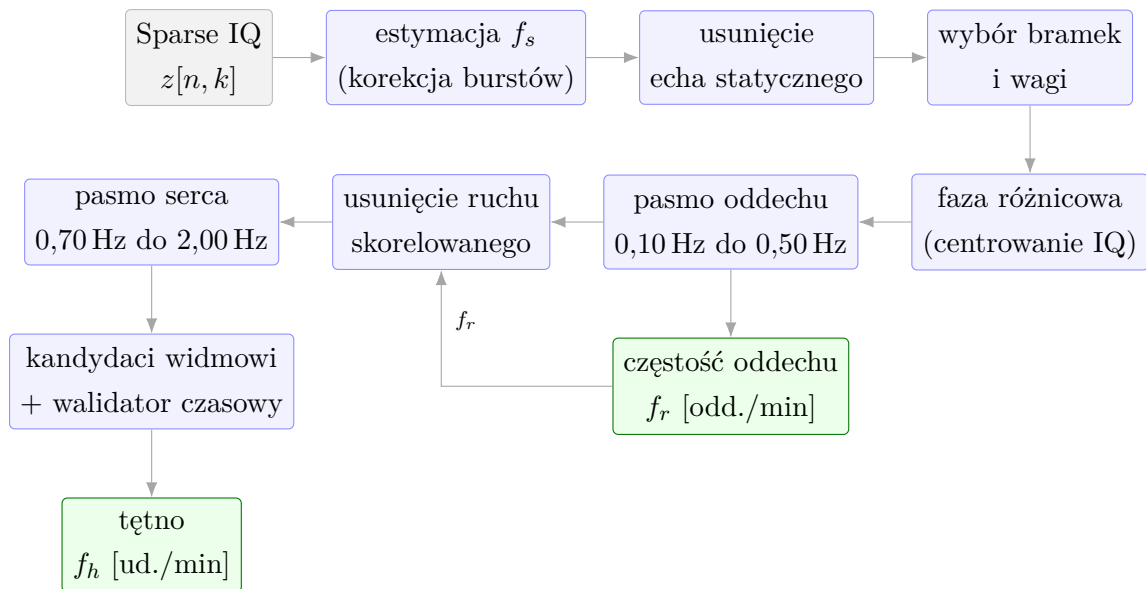
gdzie amplituda A opisuje siłę odbicia, a faza φ — drogę optyczną fali. Dla celu oddalonego o d faza sygnału odbitego wynosi $\varphi = -4\pi d/\lambda$, skąd bezpośrednio wynika

zależność wykorzystywana w całym potoku:

$$\Delta d = \frac{\lambda}{4\pi} \Delta\varphi. \quad (10.2)$$

Dla $f_0 = 60$ GHz mamy $\lambda \approx 5$ mm, a więc 1 rad zmiany fazy odpowiada zaledwie 0,4 mm przemieszczenia. To właśnie ta czułość — a nie amplituda — jest źródłem informacji o parametrach życiowych.

Skala zjawisk, które trzeba rozdzielić, jest jednak skrajnie nierówna: ruch klatki piersiowej przy spokojnym oddechu wynosi 4 mm do 12 mm, natomiast mikroruch powierzchni ciała wywołany pracą serca to zaledwie 0,2 mm do 0,5 mm. Sygnał sercowy jest więc o *rzęd do dwóch rzędów wielkości słabszy* od oddechowego i w dodatku leży w paśmie, w które wpadają harmoniczne oddechu. Cała trudność algorytmu tętna sprowadza się do tego jednego faktu i to jemu poświęcona jest sekcja 10.6.



Rysunek 10.1: Potok przetwarzania sygnału A121. Ścieżka oddechowa jest krótka i stabilna; ścieżka sercowa wymaga dodatkowo usunięcia ruchu skorelowanego z oddechem oraz walidacji kandydatów w dziedzinie czasu. Estymowana częstość oddechu f_r wraca jako parametr do toru sercowego.

10.2 Estymacja częstotliwości próbkowania

Pozornie trywialny krok okazał się pierwszym źródłem poważnych błędów. Ramki są dostarczane przez UART *paczkami*: kilka ramek trafia do hosta niemal jednocześnie (odstępów poniżej milisekundy, czasem zerowe), po czym następuje dłuższa przerwa. Naiwny estymator oparty na medianie odstępów $\hat{f}_s = 1/\text{med}(\Delta t)$ mierzy wtedy odstęp *wewnątrz paczki*, a nie rzeczywisty odstęp ramek, i zawyża f_s nawet kilkukrotnie. Ponieważ pasma filtrów są definiowane względem f_s , całe pasmo oddechowe przesun-

wało się poza rzeczywisty rytm i estymaty były bezwartościowe.

Zaimplementowany estymator (`sample_rate_from_ms`) wykrywa taką sytuację i przełącza się na estymator globalny:

$$\hat{f}_s = \begin{cases} \frac{N-1}{t_{N-1} - t_0}, & \text{gdy sygnatury czasowe są „paczkowe”,} \\ (\overline{\Delta t})^{-1}, & \text{w przeciwnym razie,} \end{cases} \quad (10.3)$$

gdzie średnia $\overline{\Delta t}$ jest liczona odpornie, tylko po odstępach z przedziału (0,25 med, 4 med). Za „paczkowe” uznaje się sygnatury, w których ponad 5% odstępów jest niedodatnich lub krótszych niż $\max(2 \text{ ms}, 0,2 \text{ med})$, albo w których obie estymaty różnią się o więcej niż 25%.

10.3 Usunięcie echa statycznego i wybór bramki odległościowej

Dominującą składową sygnału nie jest człowiek, lecz nieruchome otoczenie (ściana, rama łóżka, sam korpus czujnika). Odbicia te są stałe w czasie, więc usuwa się je filtrem górnoprzepustowym w dziedzinie ramek:

$$z_m[n, k] = z[n, k] - \text{LP}(z[\cdot, k])[n], \quad (10.4)$$

gdzie LP jest filtrem Butterwortha dolnoprzepustowym o częstotliwości granicznej równej dolnej granicy pasma oddechowego (0,10 Hz). Sygnał z_m służy do *oceny amplitudy* ramek — ale, co kluczowe, **nie do wyznaczania fazy** (patrz sekcja 10.4).

Każdą bramkę ocenia się dwoma niezależnymi kryteriami. Pierwszym jest medianowa amplituda po usunięciu echa, $\text{med}_n |z_m[n, k]|$. Drugim — stosunek energii w paśmie życiowym do energii tła:

$$R_k = \frac{\langle |\Phi_k(f)|^2 \rangle_{f \in [0,10; 2,00] \text{ Hz}}}{\langle |\Phi_k(f)|^2 \rangle_{f \in [0,03; 5] \text{ Hz} \setminus \text{pasma \textbackslash życiowe}}}, \quad (10.5)$$

gdzie Φ_k jest widmem fazy k -tej bramki. Bramka z silnym odbiciem, ale bez periodycznej modulacji (np. metalowa rama łóżka), ma wysoką amplitudę i niskie R_k — i zostaje odrzucona. Sama amplituda nie wystarcza.

Cel wybiera się jako bramkę o najwyższym łącznym wyniku, a następnie tworzy wokół niej klastery ramek w promieniu bramkowania. Sygnał wypadkowy jest średnią ważoną amplitudą, przy czym do estymacji oddechu używa się co najwyżej 3 ramek (torsu nie trzeba szerzej obejmować, a każda dodatkowa bramka wnosi szum).

10.4 Ekstrakcja fazy: dlaczego nie wprost $\arg z$

Naturalny pomysł — rozwinąć fazę residuum $\arg(z_m)$ i przefiltrować — w praktyce nie działa i był jedną z najkosztowniejszych pomyłek w projekcie. Wektor z_m po usunięciu echa statycznego jest *mały* i przy typowym, podmilimetrowym ruchu klatki piersiowej regularnie *przechodzi przez początek układu współrzędnych*. Funkcja atan2 wykonuje wtedy skok o π , którego rozwijanie fazy nie potrafi odróżnić od prawdziwego ruchu. W efekcie przebieg po filtracji pasmowej zawierał losowe skoki i płaskie odcinki.

Rozwiązanie składa się z dwóch elementów. Po pierwsze, faza jest wyznaczana z *surowego* sygnału z (którego moduł jest duży i który nie zbliża się do zera), a echo statyczne usuwa się dopiero *w dziedzinie fazy* przez centrowanie okręgu IQ. Trajektorja $z[n, k]$ dla nieruchomego tła z drgającym celem jest łukiem okręgu o środku c przesuniętym od zera; środek ten wyznacza się algebraicznym dopasowaniem okręgu (metoda Kąsy), minimalizując

$$\sum_n \left(|z[n, k] - c|^2 - r^2 \right)^2, \quad (10.6)$$

co po podstawieniu $c = (c_x, c_y)$ sprowadza się do liniowego zadania najmniejszych kwadratów. Dopasowanie przyjmuje się tylko wtedy, gdy jest wiarygodne (względny błąd promienia poniżej 0,45); w przeciwnym razie bramka zachowuje fazę surową.

Po drugie — i to jest właściwe zabezpieczenie — fazę akumuluje się *przyrostowo*, z różnic międzyramkowych, zamiast rozwijać fazę bezwzględną:

$$\Delta\varphi[n, k] = \arg(\hat{z}[n, k] \hat{z}^*[n-1, k]), \quad \varphi[n, k] = \sum_{i=1}^n \Delta\varphi[i, k], \quad (10.7)$$

gdzie $\hat{z} = z/|z|$. Kolejne próbki dzieli krótki łuk, więc $\Delta\varphi$ nigdy nie zbliża się do $\pm\pi$ i problem niejednoznaczności znika. Jest to zarazem podejście stosowane w referencyjnym procesorze oddechowym firmy Acconeer.

Łączenie bramek wykonuje się *koherentnie*, przed operacją arcus tangens:

$$\Delta\varphi[n] = \arg \left(\sum_k w_k \hat{z}[n, k] \hat{z}^*[n-1, k] \right), \quad (10.8)$$

dzięki czemu bramka o małej wadze wnosi mało energii do sumy, a nie — jak przy uśrednianiu już policzonych faz — pełnoprawny, zaszumiony kąt.

10.5 Estymacja częstości oddechu

Ścieżka oddechowa jest stosunkowo prosta, ponieważ sygnał jest silny. Sygnał fazowy jest filtrowany pasmowo w zakresie 0,10 Hz do 0,50 Hz (6–30 oddechów/min) filtrem Butterwortha 2. rzędu w implementacji zerofazowej (`sosfiltfilt`, filtracja w przód i w tył — brak przesunięcia fazowego kosztem pracy wsadowej), a częstość wyznaczana jest z położenia maksimum gęstości widmowej mocy w oknie 20 s, z interpolacją paraboliczną wokół prążka maksymalnego.

Po serii nieudanych prób własnej implementacji ostatecznie zdecydowano się oprzeć estymację częstości oddechu na **referencyjnym procesorze producenta** (`BreathingProcessor` z pakietu *Acconeer Exploration Tool*), któremu podaje się wybrany wcześniej segment bramek. Procesor ten realizuje własne usuwanie echa statycznego (filtr IIR), rozwijanie fazy, filtrację pasmową, okno Hamminga, uzupełnianie zerami i interpolację kwadratową pików. Własna implementacja pozostała jako ścieżka zapasowa na wypadek zmian w API biblioteki. Decyzja ta była jednym z przełomowych momentów projektu (commit 9d2130a, „*vital signals fix*”).

Pewność estymaty definiowana jest jako wyrazistość pików względem tła w paśmie:

$$C_r = \frac{P(f_r)}{\text{med}_{f \in \text{pasmo}} P(f)}. \quad (10.9)$$

Dodatkowo zaimplementowano **detekcję braku oddechu**: jeżeli wartość skuteczna sygnału oddechowego spada poniżej 0,005 rad (próg dobrany empirycznie dla A121, co odpowiada ruchowi rzędu pojedynczych mikrometrów), oddech jest nieodróżnialny od szumu czujnika i zamiast losowej częstotliwości raportowany jest brak wyniku. Bez tego zabezpieczenia system podczas wstrzymania oddechu pokazywał „oddech” wzięty z szumu.

10.6 Estymacja tętna — problem harmonicznym

Ruch klatki piersiowej przy oddychaniu nie jest sinusoidalny: wdech i wydech mają różne profile, przez co widmo oddechu zawiera silne harmoniczne nf_r . Dla typowej częstości spoczynkowej $f_r \approx 0,15$ Hz harmoniczne pojawiają się co 0,15 Hz, a więc w całym paśmie sercowym 0,70 Hz do 2,00 Hz leży ich kilkanaście (rzędy 5–13). Ponieważ sygnał sercowy jest 20–50 razy słabszy od oddechowego, harmoniczna oddechu bywa w paśmie serca silniejsza niż samo tętno. Prosty detektor maksimum widma wskazuje wtedy harmoniczną — i dokładnie to robiła pierwsza wersja algorytmu.

Ostateczne rozwiązanie jest kaskadą pięciu mechanizmów; żaden z nich osobno nie wystarcza.

1. Usunięcie ruchu skorelowanego z oddechem. Zamiast „wycinać” każdą harmoniczną (co niszczy tętno leżące przypadkiem w pobliżu), modeluje się nieliniowość oddechu bezpośrednio. Znormalizowany przebieg oddechowy $r[n]$ podnosi się do potęg $p = 2, \dots, 6$, każdą potęgę filtruje pasmowo do pasma serca i traktuje jako regresor. Współczynniki wyznacza regresja grzbietowa:

$$\hat{\beta} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X} + \gamma \mathbf{I})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{x}, \quad \mathbf{X}_{:,p} = \text{BP}_{\text{serce}}(r^p), \quad (10.10)$$

a od sygnału odejmuje się dopasowany artefakt *miętko*, ze współczynnikiem 0,70:

$$x_{\text{serce}}[n] = x[n] - 0,70 \cdot (\mathbf{X}\hat{\beta})[n]. \quad (10.11)$$

Niepełne odejmowanie jest celowe: dzięki niemu prawdziwe tętno leżące blisko harmonicznego przetrwa i może zostać odzyskane przez walidator z punktu 4.

2. Filtracja pasmowa i kandydaci widmowi. Sygnał filtruje się pasmowo (0,70 Hz do 2,00 Hz, Butterworth 3. rzędu, zerofazowo), a z widma mocy wybiera się nie jedno maksimum, lecz do sześciu kandydatów. Widmo jest przed wyborem modyfikowane wycięciami gaussowskimi w miejscach harmonicznym oddechu:

$$S(f) = P(f) \prod_{n=2}^7 \left[1 - 0,75 \exp \left(-\frac{1}{2} \left(\frac{f - n f_r}{\sigma_n} \right)^2 \right) \right], \quad \sigma_n = \max(0,040, 0,030 n f_r). \quad (10.12)$$

Pierwotne wycięcia były wąskie i płytkie, przez co przepuszczały większość energii harmonicznego; obecne są szersze i tłumią o -12 dB.

3. Tłumienie prążków brzegowych. Energia zbocza filtra gromadzi się w skrajnych prążkach FFT, przez co detektor regularnie „zatrząskiwał się” na dokładnie 0,70 Hz (42 ud./min — podejrzenie równa dolna granica pasma). Na obu krańcach pasma nałożono liniowe okno tłumiące o szerokości około 0,05 Hz.

4. Walidacja w dziedzinie czasu. Kluczowa obserwacja: harmoniczna oddechu jest silna *widmowo*, ale rzadko tworzy regularny ciąg uderzeń w czasie. Każdego kandydata f weryfikuje się więc, zawężając sygnał wokół f i szukając w nim ciągu pików. Ocena periodyczności łączy cztery składniki:

$$s(f) = 0,38 g + 0,27 \rho + 0,20 c + 0,15 \sigma_{\text{span}}, \quad (10.13)$$

gdzie g to frakcja odstępów międzypikowych mieszczących się w $\pm 32\%$ oczekiwanego okresu $1/f$, $\rho = \max(0, 1 - \text{CV}/0,42)$ jest miarą regularności opartą na współczynniku zmienności odstępów, c — pokryciem (stosunek liczby znalezionych pików do

oczekiwanej), a σ_{span} — częścią okna faktycznie objętą ciągiem pików.

Wynik końcowy łączy pewność widmową i periodyczność, przy czym kandydat leżący na harmonicznej i jednocześnie słabo periodyczny ($s < 0,45$) jest dodatkowo karany współczynnikiem 0,62:

$$\text{score}(f) = \eta(f) \left[C(f)(0,72 + 0,55 s(f)) + 2,8 s(f) \right]. \quad (10.14)$$

Autokorelacja pełni rolę wyłącznie *potwierdzającą*: jeśli jej wskazanie zgadza się z widmowym w granicach 0,22 Hz, wyniki są mieszane w proporcji 70/30; przy słabym widmie autokorelacja bywa zwodzona przez harmoniczne i nie jest używana samodzielnie.

5. Poszukiwanie tętna w sąsiednich bramkach. Okazało się, że mikroruch sercowy jest często najlepiej widoczny *nie* w bramce o największej amplitudzie (którą wybiera tor oddechowy), lecz na *bliższej krawędzi* odbicia od torsu. Algorytm przeszukuje więc do 13 bramek w promieniu $\pm 0,18$ m od celu, licząc niezależną estymatę w każdej z nich, i przyjmuje wynik z innej bramki tylko wtedy, gdy jest on wyraźnie lepszy (pewność ≥ 12 oraz co najmniej 1,1 raza wyższa niż estymaty głównej).

10.7 Śledzenie tętna filtrem Kalmana (podgląd na żywo)

Analizator wsadowy jest bezstanowy, ale podgląd na żywo wymaga stabilnego wskazania. Zastosowano filtr Kalmana ze stałym przyspieszeniem, o wektorze stanu $\mathbf{x} = [f, \dot{f}, \ddot{f}]^T$ i modelu

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t & \frac{1}{2}\Delta t^2 \\ 0 & 1 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{Q} = \mathbf{G}\mathbf{G}^T \rho_a^2, \quad \rho_a = 0,065 \text{ Hz/s}^2. \quad (10.15)$$

Wariancja pomiaru jest wiązana z pewnością widmową, $\sigma_z = \text{clip}(0,22/\sqrt{C}, 0,035, 0,22)$, więc pewne estymaty korygują stan mocniej. Odstające pomiary odrzuca bramka chi-kwadrat na innowacji ($d^2 \leq 9$), z poszerzeniem po czterech odrzuceniach z rzędu, aby filtr mógł odzyskać śledzenie po zmianie tętna. Po 12 nieudanych aktualizacjach filtr się resetuje. Bieżący stan jest podawany z powrotem do estymatora jako zawężone pasmo poszukiwań — to on zapobiega przeskokom wskazania na harmoniczne.

10.8 Miary pewności i bramki decyzyjne

Każda estymata jest publikowana tylko wtedy, gdy przejdzie zestaw bramek: oddech wymaga co najmniej 20 s historii i pewności $C_r \geq 4$, tętno — co najmniej 10 s i $C_h \geq 5$; brak wykrytej obecności zeruje oba wyniki. Zbiorczy wskaźnik *signal_quality* $\in [0, 1]$ jest ważoną sumą logarytmu kontrastu amplitudowego, obu pewności oraz stosunku energii pasmowej (10.5).

Uczciwe zastrzeżenie. Jak wynika z eksperymentu opisanego w następnym rozdziale (11), wskaźniki te **osiągają wartość maksymalną we wszystkich 36 nagraniach** wykonanych na siedząco do 1 m. Są więc użyteczne jako zabezpieczenie przed publikowaniem szumu, ale *nie nadają się* do porównywania jakości konfiguracji sprzętowych — do tego trzeba sięgnąć po miary widmowe liczone poza potokiem.

10.9 Historia: co nie działało i dlaczego

Poniższe zestawienie odtworzono z historii repozytorium. Warto je czytać jako ostrzeżenie: każdy z tych błędów dawał przebieg, który „wyglądał prawie dobrze” i żaden nie objawiał się wyjątkiem ani komunikatem o błędzie.

Tabela 10.1: Kolejne awarie potoku przetwarzania, ich przyczyny i zastosowane rozwiązania.

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Częstości przesunięte o dziesiątki procent	Ramki dostarczane paczkami; mediana odstępów mierzy odstęp <i>wewnątrz</i> paczki, nie między ramkami	Estymator globalny $f_s = (N-1)/(t_{N-1}-t_0)$ przy wykryciu paczkowości, równanie (10.3)
Przebieg z losowymi skokami i płaskimi odcinkami	Faza brana z residuum po usunięciu echa; mały wektor przechodzi przez zero, atan2 skacze o π	Faza z sygnału surowego + akumulacja różnic międzyramkowych, równanie (10.7)
Podgląd na żywo psuje się po kilku minutach	Skumulowana faza narasta monotonicznie (rzędu 1400 rad) i nasycza stan filtru IIR	Filtr górnoprzepustowy 1. rzędu 0,04 Hz (poniżej pasma oddechu) przed filtracją pasmową

ciąg dalszy na następnej stronie

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Przebieg na żywo zapada się w linię prostą	Sąsiednie bramki o przeciwnej fazie znoszą się w średniej ważonej	Dominująca waga 0,65 dla bramki wybranej (tryb live); retrospektywne wyrównanie znaku (tryb wsadowy)
Niestabilna częstość oddechu	Własna implementacja estymatora	Referencyjny BreathingProcessor Acconeera; własny tor jako zapasowy
Tętno przeskakuje między harmonicznymi oddechu	Zbyt szerokie pasmo (0,65 Hz do 3,00 Hz) i zbyt wąskie wycięcia harmonicznym	Zawężenie pasma do 0,70 Hz do 2,00 Hz; szersze i głębsze wycięcia gaussowskie, równanie (10.12)
Tętno „przykleja się” do 42 ud./min	Energia zbocza filtra gromadzi się w skrajnym prążku FFT	Okno tłumiące o szerokości 0,05 Hz na krańcach pasma
Tętno znika mimo dobrego sygnału	Twarda reguła zerująca estymatę leżącą blisko harmonicznej — a prawdziwe tętno leży tam bardzo często	Usunięcie reguły; zastąpienie jej miękką regresją (10.10) i walidatorem czasowym (10.13); próg pewności obniżony z 14 do 5
Tętno niewidoczne w bramce celu	Mikroruch sercowy najsilniejszy na bliższej krawędzi torsu, nie w maksimum amplitudy	Przeszukiwanie do 13 bramek w promieniu $\pm 0,18$ m

Widać w tym wyraźny wzorec: *wszystkie* poważne błędy wynikały z operowania na fazie w sposób, który był poprawny matematycznie, ale niestabilny numerycznie przy rzeczywistych, słabych sygnałach. Ewolucję pasm podsumowuje tabela 10.2.

Tabela 10.2: Zmiany pasm filtrów w kolejnych wersjach algorytmu. Systematyczne zawężanie pasm było reakcją na przeskok estymacji na harmoniczne i artefakty ruchu.

Wersja	Pasmo oddechu	Pasmo serca	Uwagi
b9f49e8 (31.05)	0,08 Hz do 0,70 Hz	0,65 Hz do 3,00 Hz	pierwsza wersja
7924d95 (31.05)	0,10 Hz do 0,70 Hz	0,65 Hz do 3,00 Hz	korekta f_s , tryb live
9d2130a (01.06)	0,10 Hz do 1,00 Hz	0,65 Hz do 3,00 Hz	procesor Acconeera
bf82a08 (11.06)	0,10 Hz do 0,50 Hz	0,70 Hz do 2,00 Hz	wersja obecna

10.10 Zestawienie parametrów

Tabela 10.3: Parametry potoku estymacji parametrów życiowych (wartości domyślne).

Parametr	Znaczenie	Wartość
A121_RESP_BAND_HZ	pasmo oddechowe	0,10 Hz do 0,50 Hz
HEART_BAND_HZ	pasmo sercowe	0,70 Hz do 2,00 Hz
A121_RATE_WINDOW_S	okno estymacji częstości	20 s
DEFAULT_GATE_HALF_WIDTH_M	połowa szerokości bramki	0,05 m
HEART_RANGE_HALF_WIDTH_M	promień poszukiwań tętna	0,18 m
HEART_RANGE_MAX_BINS	maks. liczba bramek tętna	13
RESP_RATE_CONFIDENCE_MIN	próg publikacji oddechu	4,0
HEART_RATE_CONFIDENCE_MIN	próg publikacji tętna	5,0
A121_MIN_TARGET_DISTANCE_M	min. odległość celu	0,28 m
—	rząd filtru oddechowego	2
—	rząd filtru sercowego	3
—	próg braku oddechu (RMS)	0,005 rad

10.11 Oprogramowanie

*Miejsce zarezerwowane: Aplikacja desktopowa (PyQt + pyqtgraph): podgląd na żywo z czterech torów, nagrywanie do CSV i SQLite, przeglądanie historii. Interfejs CLI (**respi**) do akwizycji wsadowej i generowania wykresów. Struktura pakietu **respi_net**. Zrzuty ekranu aplikacji do dodania.*

Rozdział 11

Eksperyment: soczewki dielektryczne i wzmacnianie odbicia

11.1 Cel i hipotezy

Celem eksperymentu było sprawdzenie dwóch hipotez:

1. wybór soczewki dielektrycznej istotnie wpływa na jakość sygnału oddechowego rejestrowanego przez radar A121,
2. naklejenie na klatkę piersiową łąty z folii aluminiowej ($5\text{ cm} \times 5\text{ cm}$) wzmacnia odbicie i poprawia jakość sygnału.

Druga hipoteza jest o tyle istotna, że sama amplituda odbicia nie jest wystarczającym kryterium — silniejsze odbicie może współwystępować z gorszym stosunkiem sygnału oddechowego do szumu.

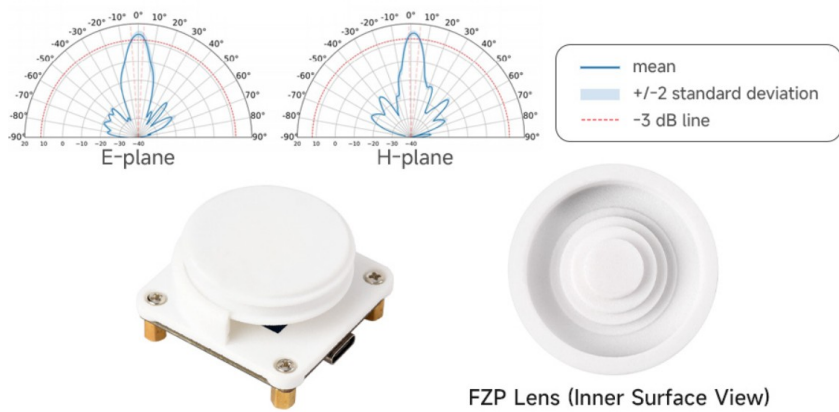
Jak opisano w sekcji 3.6, folia jest dla fal 60 GHz praktycznie nieprzezroczystym przewodnikiem i silnym reflektorem. Nie wynika z tego jednak, że niewielka łąta poprawi pomiar człowieka. Radar już otrzymuje rozłożone przestrzennie odbicie od bogatych w wodę tkanek, a dodanie metalowej powierzchni może zmienić dominującą bramkę, fazę i tory wielodrogowe. Hipotezę należy więc sprawdzać na podstawie SNR i powtarzalności estymacji, a nie na podstawie samej przewodności aluminium.

11.2 Badane soczewki

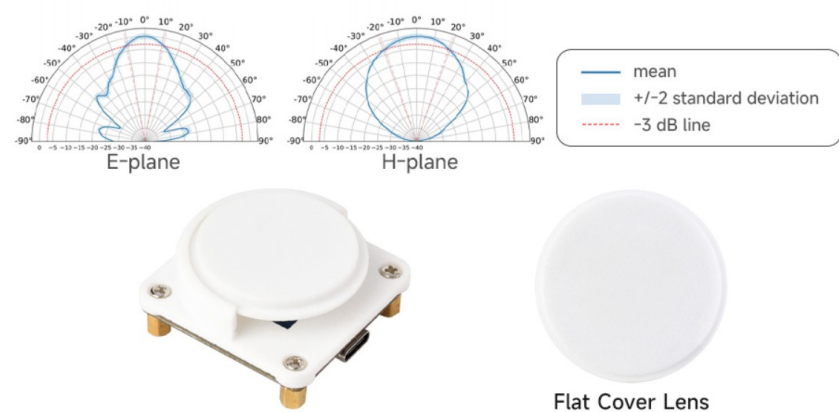
Porównano trzy warianty przesłony czujnika (rys. 11.1): soczewkę hiperboliczną (refrakcyjną), soczewkę FZP (dyfrakcyjną płytkę strefową Fresnela) oraz płaską pokrywę bez własności skupiających.



(a) Soczewka hiperboliczna — wąska wiązka igłowa, niskie listki boczne.



(b) Soczewka FZP — porównywalny zysk, wyraźnie silniejsze listki boczne.



(c) Płaska pokrywa — brak skupiania, szeroka wiązka.

Rysunek 11.1: Badane warianty przesłony czujnika A121 wraz z charakterystykami promieniowania w płaszczyznach E i H (materiały producenta [5]).

11.3 Metodyka

Zrealizowano plan pełny: 3 soczewki $\times$ 2 odległości (50 cm i 100 cm) $\times$ 2 stany folii (naklejona / brak) = 12 warunków, każdy powtórzony trzykrotnie, co dało **36 nagrań** po 60 s (około 1200 ramek każde). Akwizycję prowadzono sterowaną procedurą (`tools/a121_guided_experiment.py`), która prowadzi operatora przez kolejne warunki.

Radar był zamocowany na fotograficznym statywie Manfrotto. Odległości 50 cm i 100 cm ustawiano za pomocą dalmierza laserowego MILESEET D2 w wariancie 40 m; producent deklaruje dla rodziny D2 dokładność pomiaru odległości ± 2 mm [6]. Plamkę lasera wykorzystywano również do orientacyjnej kontroli kierunku osi stanowiska, tak aby wypadła na centralnym obszarze klatki piersiowej. W obrębie danej serii nie zmieniano wysokości ani nachylenia statywu.



Rysunek 11.2: Moduł A121 w wymiennej przesłonie zamocowany do głowicy fotograficznego statywu Manfrotto. Głowica umożliwiała zablokowanie kierunku osi, a to samo mocowanie wykorzystywano w serii przy 50 cm i 100 cm. Na zdjęciu widoczna jest płaska pokrywa; w pozostałych warunkach wymieniano wyłącznie przedni element optyczny.

Badany siedział na krześle w naturalnej, niewymuszonej pozycji. Oś radaru utrzymywano równoległe do podłoża, co kontrolowano poziomnicą pęcherzykową wbudowaną w dalmierz. Ze względu na naturalne pochylenie tułowia oś radaru była odchy-

lona o około 30° od normalnej do powierzchni klatki piersiowej, czyli kąt padania wynosił w przybliżeniu 30° . W serii z folią stosowano kwadrat o wymiarach $5\text{ cm} \times 5\text{ cm}$, umieszczony tak, aby jego górna krawędź znajdowała się 5 cm poniżej poziomej linii łączącej brodawki sutkowe.

Dla każdego nagrania wyznaczono: amplitudę odbicia w bramkach klatki piersiowej, stosunek sygnału oddechowego do szumu (SNR — maksimum widma w paśmie 0,08 Hz do 0,60 Hz względem mediany tła 1 Hz do 5 Hz), wyrazistość piku widmowego, stabilność śledzonej odległości celu, amplitudę przemieszczenia oddechowego oraz poziom szumu ruchowego w paśmie 4 Hz do 8 Hz.

Ograniczenie metodyczne. Kolejność pomiarów nie była randomizowana — wszystkie nagrania z folią wykonano przed wszystkimi nagraniami bez folii, w dwóch różnych sesjach (13 i 14 lipca 2026). Efekt folii jest więc splątany z efektem sesji (postawa, ustawienie czujnika, stan badanego). Porównania między soczewkami są natomiast zrównoważone względem sesji i pozostają wiarygodne.

11.4 Wyniki: porównanie soczewek



Rysunek 11.3: Medianowa amplituda sygnału w funkcji odległości dla wszystkich 36 nagrań. Kolumny odpowiadają soczewkom, a wiersze odległościom 50 cm i 100 cm. Każda cienka krzywa jest medianą po czasie z jednego nagrania (po trzy powtórzenia); linia ciągła oznacza folię, przerywana jej brak, a pionowa kropkowana — odległość nominalną. Logarytmiczna oś pionowa pokazuje jednocześnie pik klatki i słabsze odbicia tła. Soczewki skupiające dają 3–10-krotnie wyższy pik; przy 100 cm pik płaskiej pokrywy jest szeroki i słabo oddzielony od sąsiednich bramek.

Na rysunku 11.3 nie należy porównywać wyłącznie wysokości najwyższego punktu. Wąski, powtarzalny pik oznacza, że energia wraca z tego samego fragmentu tułowia, natomiast szeroki profil może obejmować kilka części ciała i tło. To wyjaśnia, dlaczego płaska pokrywa przy 100 cm może nadal rejestrować oddech, a zarazem niestabilnie wybierać bramkę celu.

Tabela 11.1: Uśrednione metryki dla każdej soczewki i odległości (n=6: oba stany folii $\times$ 3 powtórzenia).

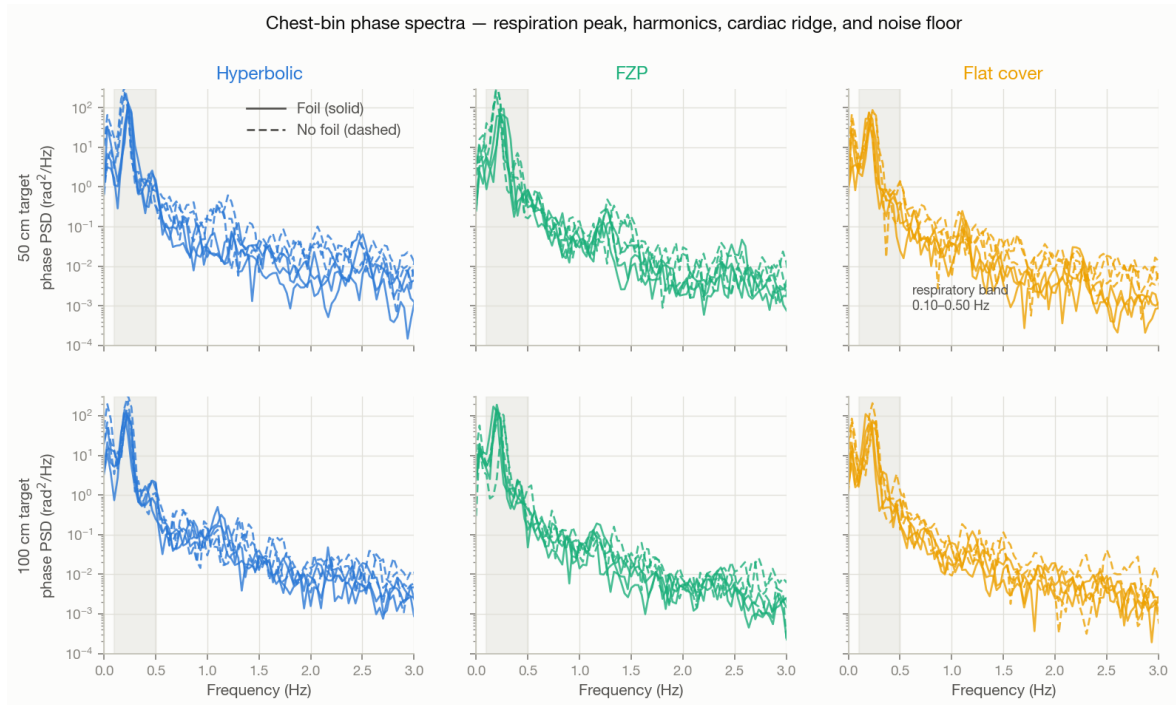
Odległość	Soczewka	Amplituda [j.u.]	SNR [dB]	Odch. std. odl. [cm]	Przemieszcz. [mm]
50 cm	Hiperboliczna	3100	45,3	1,0	2,20
	FZP	3020	46,6	1,2	2,45
	Płaska pokrywa	970	43,8	3,5	1,56
100 cm	Hiperboliczna	1245	45,7	2,4	2,23
	FZP	697	47,3	3,7	2,10
	Płaska pokrywa	322	45,9	8,9	1,79

Wyniki prowadzą do trzech obserwacji:

Amplituda. Przy 50 cm obie soczewki skupiające są równoważne (mediana ok. 3000 j.u.) i około trzykrotnie lepsze od płaskiej pokrywy. Przy 100 cm soczewka hiperboliczna wyraźnie wygrywa — zachowuje 40% amplitudy z 50 cm, podczas gdy FZP tylko 23%, co daje jej około 1,8-krotną przewagę. Jest to spójne z naturą soczewki FZP, której ogniskowanie jest zoptymalizowane dla konkretnej odległości ogniskowej, podczas gdy soczewka hiperboliczna kolimuje wiązkę.

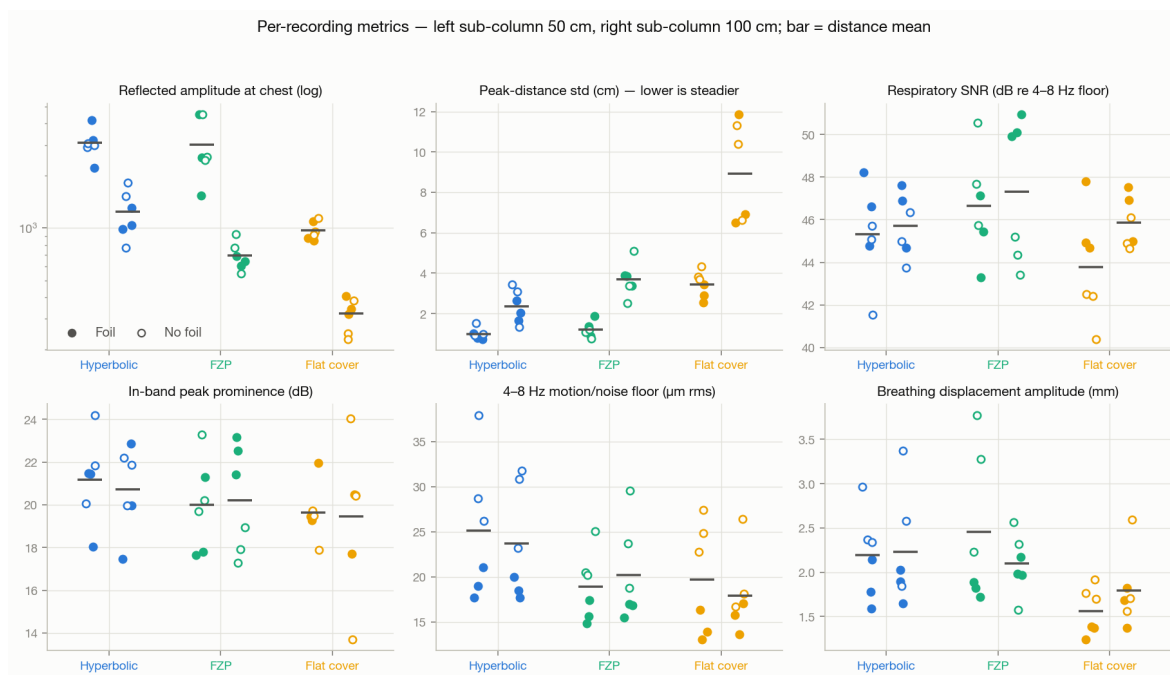
Stabilność śledzenia celu. Metryka ta różnicuje soczewki najsilniej. Odchylenie standardowe śledzonej odległości piksu rośnie od 1,0 cm (hiperboliczna, 50 cm) do 8,9 cm (płaska pokrywa, 100 cm). Przy metrze odległości płaska pokrywa utrzymuje cel w dominującej bramce jedynie w 14–54% ramek — szeroka wiązka oświetla jednocześnie tors, ramiona i tło, przez co „najsilniejszy odbłysek” przeskakuje między obiektami. Logarytm amplitudy niemal idealnie przewiduje stabilność śledzenia ($\rho_{\text{Spearman}} = -0,93$).

SNR oddechowy — brak różnic. Najistotniejszy wynik: stosunek sygnału oddechowego do szumu wynosi 44–47 dB *niezależnie* od soczewki, a amplituda w ogóle go nie przewiduje ($\rho = 0,08$; $p = 0,64$). Żadna z par soczewek nie różni się istotnie statystycznie. Przy zapasie SNR rzędu 40 dB dziesięciokrotna przewaga amplitudy nie przekłada się na wykrywalność oddechu.



Rysunek 11.4: Widma gęstości mocy sygnału fazowego z bramek klatki piersiowej; układ paneli i rodzaje linii są takie jak na rys. 11.3, a każda krzywa odpowiada jednemu nagraniu. Zacieniono pasmo oddechowe 0,10 Hz do 0,50 Hz; jego główny pik leży zwykle w okolicy 0,20 Hz do 0,27 Hz, a słabszy składnik w pobliżu dwukrotności tej częstotliwości jest harmoniczną niesinusoidalnego ruchu klatki. Oś mocy jest logarytmiczna. Wybór soczewki niemal nie zmienia odległości pików od lokalnego tła widmowego.

Wysokość krzywej na rys. 11.4 opisuje zmienność *fazy*, a nie bezpośrednio moc odbitego echa z rys. 11.3. Dlatego słabsza amplituda IQ może współistnieć z wyraźnym pikiem oddechu. Składowych w okolicy 1 Hz do 1,5 Hz nie interpretowano jako pewnego tętna bez niezależnego wzorca; mogą zawierać zarówno mikroruch sercowy, jak i harmoniczne oraz ruch. Wykres kończy się przy 3 Hz, natomiast mianownik raportowanego SNR wyznaczano osobno z pasma 4 Hz do 8 Hz.



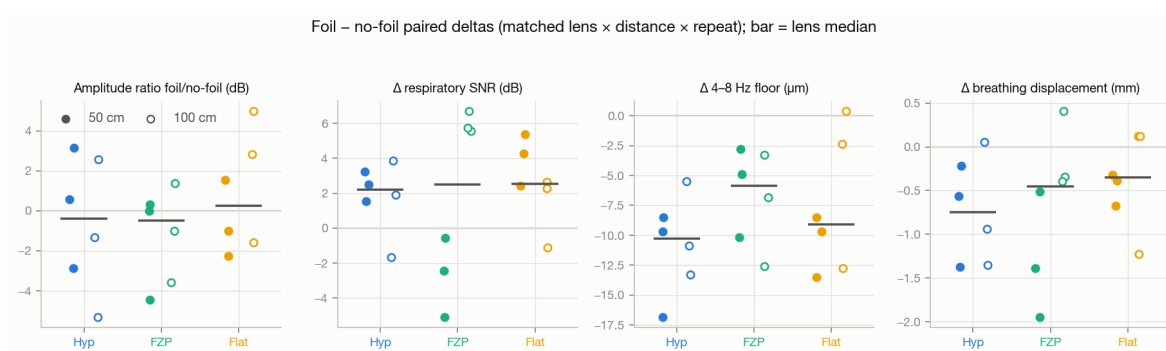
Rysunek 11.5: Wszystkie metryki dla 36 nagrań. Każdy punkt oznacza jedną próbę; punkty wypełnione — folię, puste — brak folii, a lewa/prawa podkolumna w obrębie soczewki — odpowiednio 50 cm/100 cm. Pozioma kreska jest średnią dla danego dystansu z obu stanów folii i trzech powtórzeń. W panelach amplitudy, SNR, wyrazistości pików i przemieszczenia większa wartość oznacza silniejszą składową; dla odchylenia odległości i szumu 4 Hz do 8 Hz korzystna jest wartość mniejsza. Amplituda i stabilność śledzenia wyraźnie różnicują soczewki, natomiast SNR i wyrazistość pików — nie.

Dodatkowo zaobserwowano, że płaska pokrywa *zaniża* amplitudę przemieszczenia oddechowego (1,6–1,8 mm wobec 2,1–2,5 mm dla soczewek skupiających, $p \leq 0,009$) — szeroka wiązka uśrednia fazę po dużym, niejednorodnie poruszającym się obszarze tłułowia.

11.5 Wyniki: wpływ folii aluminiowej

Tabela 11.2: Parowane różnice (folia — brak folii) dopasowane po soczewce, odległości i numerze powtórzenia (18 par, test Wilcoxon).

Metryka	Mediana różnicy	Folia lepsza	p
Amplituda odbicia	−0,5 dB	8/18	0,64
SNR oddechowy	+2,5 dB	13/18	0,012
Szum ruchowy 4 Hz do 8 Hz	−9,1 μm	1/18	< 0,0001
Amplituda przemieszczenia	−0,46 mm	4/18	0,001
Stabilność odległości	−0,18 cm	6/18	0,18
Wyrazistość pików	≈ 0	10/18	0,87



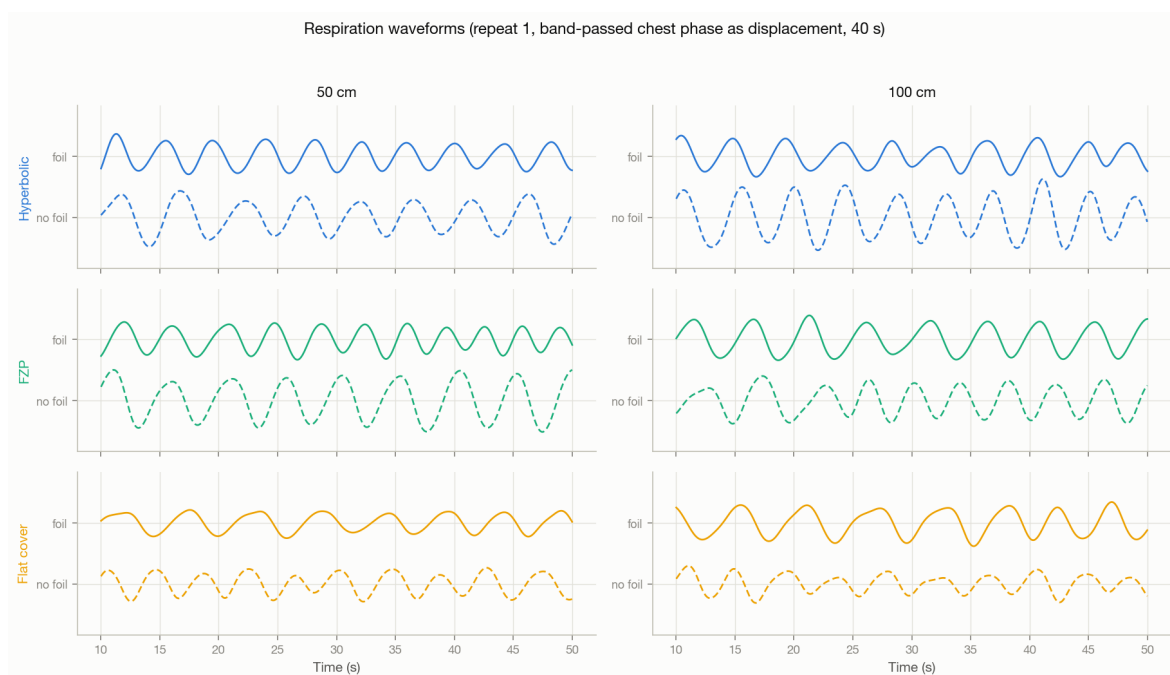
Rysunek 11.6: Parowane różnice folia – brak folii po dopasowaniu soczewki, dystansu i numeru powtórzenia. Każdy punkt jest jedną parą; punkty wypełnione oznaczają 50 cm, puste 100 cm, pozioma kreska — medianę dla soczewki, a linia zera — brak zmiany. Dodatnia wartość oznacza wzrost danej metryki z folią; w panelu szumu wartość ujemna jest więc korzystna. Amplituda oscyluje wokół zera, natomiast podobny dla wszystkich soczewek spadek szumu jest sygnaturą różnicy sesji, a nie selektywnego działania reflektora.

Nie zaobserwowano oczekiwanego wzrostu amplitudy. Łata z folii miała działać przez zwiększenie odbicia, lecz różnica amplitudy oscyluje wokół zera (mediana $-0,5$ dB, 8/18 par na korzyść folii, $p = 0,64$) dla każdej soczewki i obu odległości. Dane wskazują więc, że na dystansie 50 cm do 100 cm wkład łaty o boku 5 cm nie dał mierzalnego wzrostu na tle odbicia od całego tułowia. Ze względu na rozdzielenie sesji nie można jednak z tych danych wyznaczyć czystego efektu folii na SNR.

Znaczenie kąta padania. Geometria stanowiska mogła dodatkowo osłabić oczekiwany efekt metalowej łaty. Przy kącie około 30° względem normalnej silna składowa zwierciadlana odbicia od przewodzącej powierzchni może zostać skierowana poza antenę odbiorczą zamiast wrócić do radaru. Folia przylegała do niepłaskiej, poruszającej się powierzchni ciała, dlatego nie można traktować jej jak idealnego lustra, ale wynik dotyczy właśnie tej realistycznej geometrii siedzącej. Stały sposób ustawienia we wszystkich warunkach nie zaburza porównania soczewek, ogranicza natomiast uogólnienie wniosku o folii na padanie prostopadłe.

Pozorna poprawa SNR to prawdopodobnie efekt sesji. Wzrost SNR o 2,5 dB jest istotny statystycznie, ale wynika wyłącznie z *mianownika*: poziom szumu ruchowego w paśmie 4 Hz do 8 Hz był niższy w 17 z 18 par, i to w podobnym stopniu dla wszystkich trzech soczewek — także dla płaskiej pokrywki, gdzie fizyka wiązki czyniłaby ewentualny wkład folii najslabszym. Jednocześnie amplituda przemieszczenia oddechowego również była niższa w sesji z folią. Najprostsze wyjaśnienie: badany siedział spokojniej i oddychał płycej podczas sesji nocnej 13 lipca niż wieczorem 14 lipca. Prawdziwego mechanizmu (folia tłumiąca mikroruchy skóry) nie da się całkowicie wykluczyć, ale przewidywałby on wzrost amplitudy i zależność od soczewki

— żadne z tych zjawisk nie występuje.



Rysunek 11.7: 40 sekund przefiltrowanego sygnału przemieszczenia klatki piersiowej (fragment 10s do 50s) z pierwszego powtórzenia każdego z 12 warunków. Wiersze odpowiadają soczewkom, kolumny dystansom, linia ciągła oznacza folię, a przerywana jej brak. Przebiegi przesunięto pionowo, aby się nie nakładały, dlatego ich poziom zerowy nie ma znaczenia; porównywać należy amplitudę i regularność. Wszystkie są czytelne, lecz płaska pokrywa daje wyraźnie mniejszą amplitudę ruchu.

11.6 Wnioski z eksperymentu

1. Na dystansie 0,5m do 1,0m system *nie jest ograniczony amplitudą* — SNR oddechowy wynosi 44–47 dB niezależnie od konfiguracji. Dodatkowa moc odbita przekłada się na *stabilność śledzenia celu*, a nie na wykrywalność oddechu.
2. Soczewka hiperboliczna jest najlepszym wyborem domyślnym: najlepiej utrzymuje amplitudę na większym dystansie i najstabilniej śledzi cel.
3. Na dystansie 0,5m do 1,0m nie wykazano wzrostu amplitudy dzięki folii. Rozdzielenie warunków na dwie sesje uniemożliwia natomiast przypisanie folii zaobserwowanej różnicy SNR. Praktyczna korzyść przy małym zapasie sygnału pozostaje nierozstrzygnięta.
4. Wskaźniki pewności wbudowane w pipeline (*resp_confidence*, *signal_quality*) osiągają wartości maksymalne we wszystkich 36 nagraniach, przez co nie różnicują warunków — do oceny jakości sygnału konieczne są miary widmowe.

11.7 Retest folii i kąta padania na dystansie 2 m

11.7.1 Plan pomiaru

Retest wykonano 15 lipca 2026 wyłącznie z soczewką hiperboliczną, ponieważ poprzedni eksperyment wskazał ją jako najpewniejszy wariant na większy dystans. Zastosowano układ 2×2 : naturalna pozycja siedząca z osią radaru poziomą (około 30° od normalnej do klatki) oraz ustawienie prawie prostopadłe, każde bez folii i z folią. Warunki oznaczono odpowiednio N0, NF, P0 i PF. Każdy z nich powtórzono trzykrotnie, uzyskując 12 zaakceptowanych nagrań po 90 s (1801–1802 ramek, około 20 Hz). Radar obejmował zakres 1,5 m do 2,5 m, używał profilu 3, HWAAS 32 i ośmiu pręmiatań na ramkę.

Odległość nominalną 2 m ustawiono dalmierzem MILESEY D2. W pozycji naturalnej poziome ustawienie osi kontrolowano poziomnicą pęcherzykową. W pozycji prawie prostopadłej kąt weryfikowano zwrotem plamki lasera na kartkę odniesienia przy dalmierzu: powrót w pobliże punktu emisji oznaczał, że normalna do lokalnego fragmentu powierzchni była zbliżona do osi radaru. Nie jest to laboratoryjny pomiar kąta płaskiej próbki — klatka i przylegająca folia są zakrzywione — lecz kontrola usuwa główny błąd polegający na skierowaniu odbicia zwierciadlanego poza odbiornik. Łata miała ponownie wymiary $5\text{ cm} \times 5\text{ cm}$, a jej górna krawędź znajdowała się 5 cm poniżej linii łączącej brodawki sutkowe.

Najpierw wykonano wszystkie próby z folią, a następnie wszystkie bez folii, aby przykleić i zdjąć łatę tylko raz. Dokładna kolejność wynosiła NF, PF, PF, NF, NF, PF, P0, N0, N0, P0, P0, N0; geometrie były więc przeplatane wewnątrz każdego bloku, ale stan folii pozostaje całkowicie splątany z czasem sesji. Wyniki folii są z tego powodu opisowe, natomiast porównanie kąta jest znacznie lepiej zabezpieczone przed monotonicznym dryfem.

Każde nagranie zawierało ten sam protokół: 10 s oddechu swobodnego, 7 cykli sterowanych (wdech 2 s, wydech 3 s), 15 s wstrzymania oddechu po wydechu i 6 kolejnych cykli sterowanych. Zadana częstota wynosiła więc dokładnie 0,20 Hz, czyli 12 oddechów/min.

11.7.2 Rekonstrukcja sygnału i synchronizacja komend

Dla każdego nagrania wyznaczono medianowy profil amplitudy IQ i bramkę celu. W otoczeniu $\pm 20\text{ cm}$ od celu zachowano bramki o medianowej amplitudzie co najmniej 25% lokalnego maksimum, rozpleciono ich fazę, usunięto trend liniowy i obliczono średnią ważoną amplitudą. Fazę przeliczono na ruch radialny zależnością $x = \lambda\varphi/(4\pi)$ dla częstotliwości 60,5 GHz, po czym zastosowano zerofazowy filtr Butterwortha drugiego rzędu 0,10 Hz do 0,50 Hz.

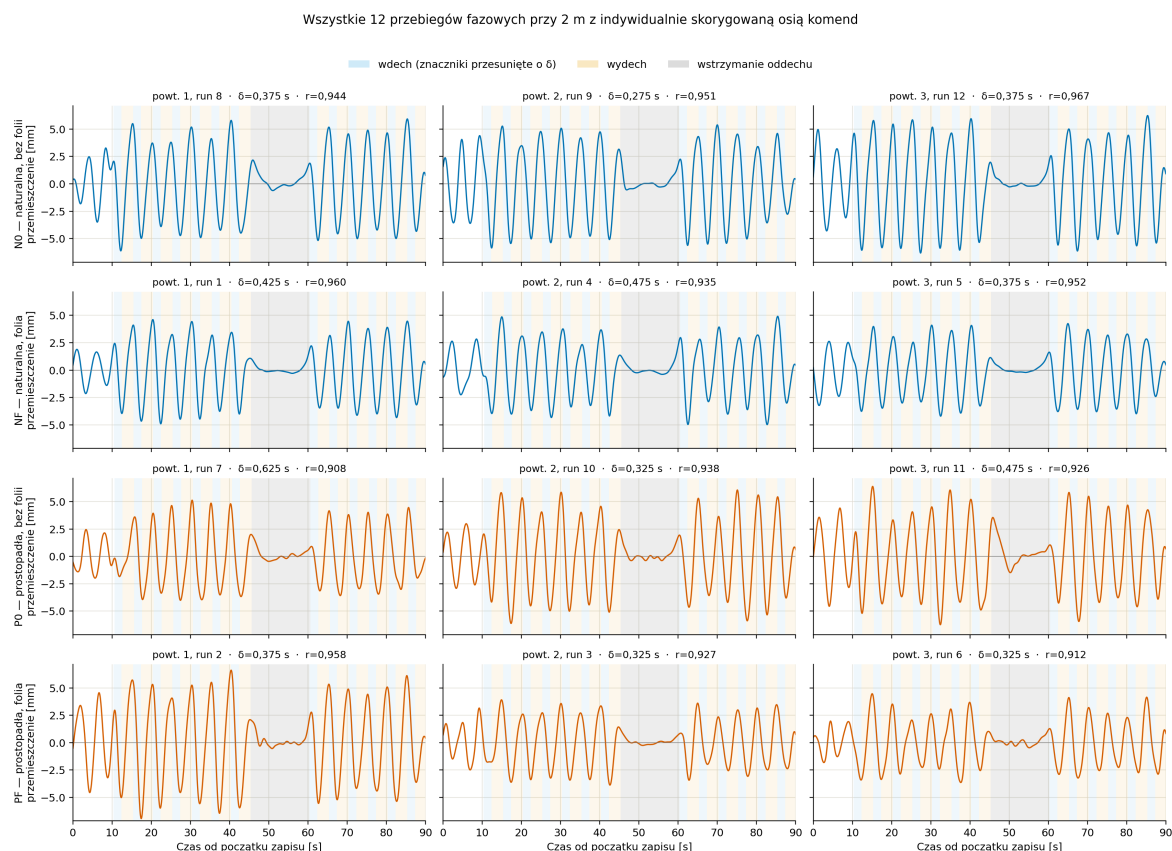
Znaczników z aplikacji nie nałożono bezpośrednio na czas ramek. Dla odcinków sterowanych utworzono trójkątny wzorzec: faza maleje podczas wdechu i rośnie podczas wydechu. Następnie dla każdej próby szukano przesunięcia w kroku 25 ms, które maksymalizowało korelację Pearsona między wzorcem i sygnałem. Oszacowane łączne opóźnienie komenda–zarejestrowany ruch mieściło się w zakresie 0,275 s do 0,625 s, z medianą 0,375 s. Maksima rozpoczynające wdech występowały medianowo 0,273 s po komendzie, a minima kończące wdech — 0,499 s po komendzie. Różnica wskazuje, że oddech nie jest jedynie idealnym wzorcem przesuniętym w czasie: badany reaguje szybko, ale domyka ruch wdechowy nieco później.

Oszacowanie obejmuje łącznie reakcję człowieka, opóźnienie akwizycji i przetwarzanie A121. Pliki nie zawierają wspólnego sprzętowego znacznika komendy i emisji ramki, dlatego tych składowych nie można rozdzielić. Zerofazowy filtr użyty offline nie wnosi natomiast dodatkowego przesunięcia fazowego. Na rys. 11.8 granice faz przesunięto osobno dla każdego nagrania o jego oszacowane δ .

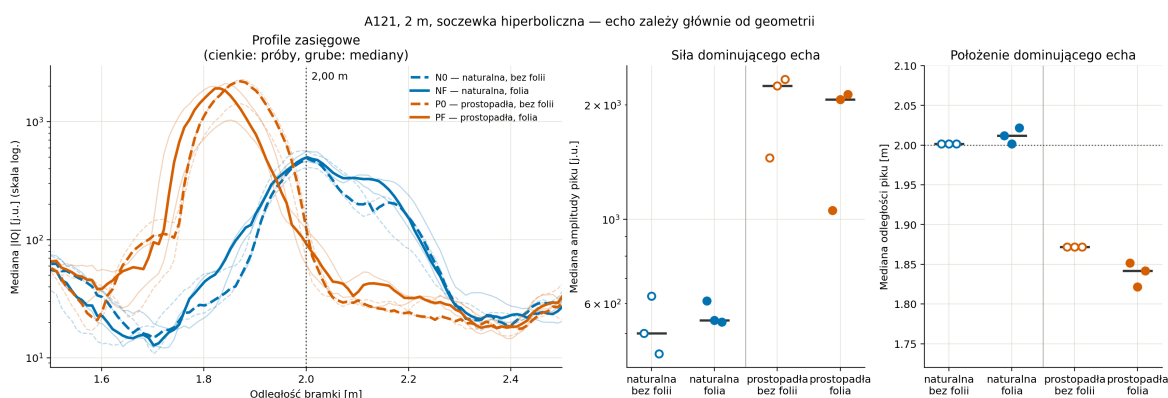
11.7.3 Wyniki retestu

Tabela 11.3: Mediany z trzech powtórzeń każdego warunku przy 2 m. σ_d jest odchyleniem standardowym położenia dominującego piku, A_{od} — połowę zakresu między 5. i 95. percentylem ruchu w odcinkach sterowanych, a *hold* — $20 \log_{10}$ ilorazu RMS fazy oddechowej w środkowych 9 s wstrzymania i RMS podczas oddychania.

Warunek	Echo [j.u.]	Bramka [m]	σ_d [cm]	r [–]	δ [s]	A_{od} [mm]	Hold [dB]
NO	501	2,002	5,31	0,951	0,375	4,78	–23,7
NF	543	2,012	5,37	0,952	0,425	3,76	–24,3
PO	2247	1,872	1,06	0,926	0,475	4,83	–20,0
PF	2068	1,842	1,25	0,927	0,325	3,18	–23,6



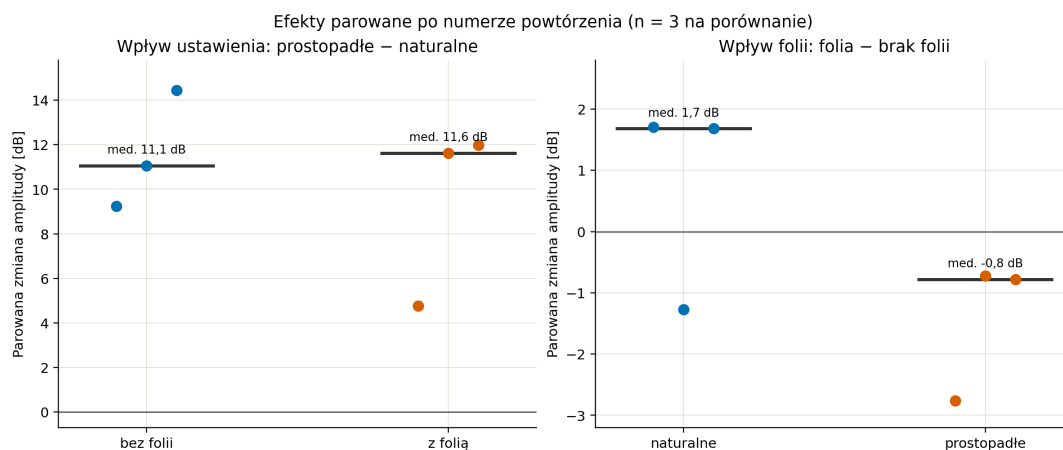
Rysunek 11.8: Wszystkie 12 przebiegów przemieszczenia oddechowego przy 2 m. Wiersze odpowiadają warunkom, a kolumny numerom powtórzeń; nad panelem podano numer w kolejności sesji, indywidualne przesunięcie δ i korelację r . Tło niebieskie oznacza wdech, pomarańczowe wydech, a szare wstrzymanie. Wspólna skala pionowa ujawnia zarówno różnice głębokości oddechu, jak i silny zanik ruchu w środkowej części wstrzymania.



Rysunek 11.9: Profile zasięgowe i echo przy 2 m. W lewym panelu cienka krzywa jest medianą po czasie z jednej próby, a gruba medianą trzech prób; linie niebieskie oznaczają pozycję naturalną, pomarańczowe prawie prostopadłą, ciągłe folię, a przerywane jej brak. Linia pionowa wskazuje dystans nominalny ustawiony dalmierzem. Środkowy panel pokazuje medianową amplitudę dominującego piku, prawy jego położenie; punkty to próby, a czarne kreski mediany warunków.

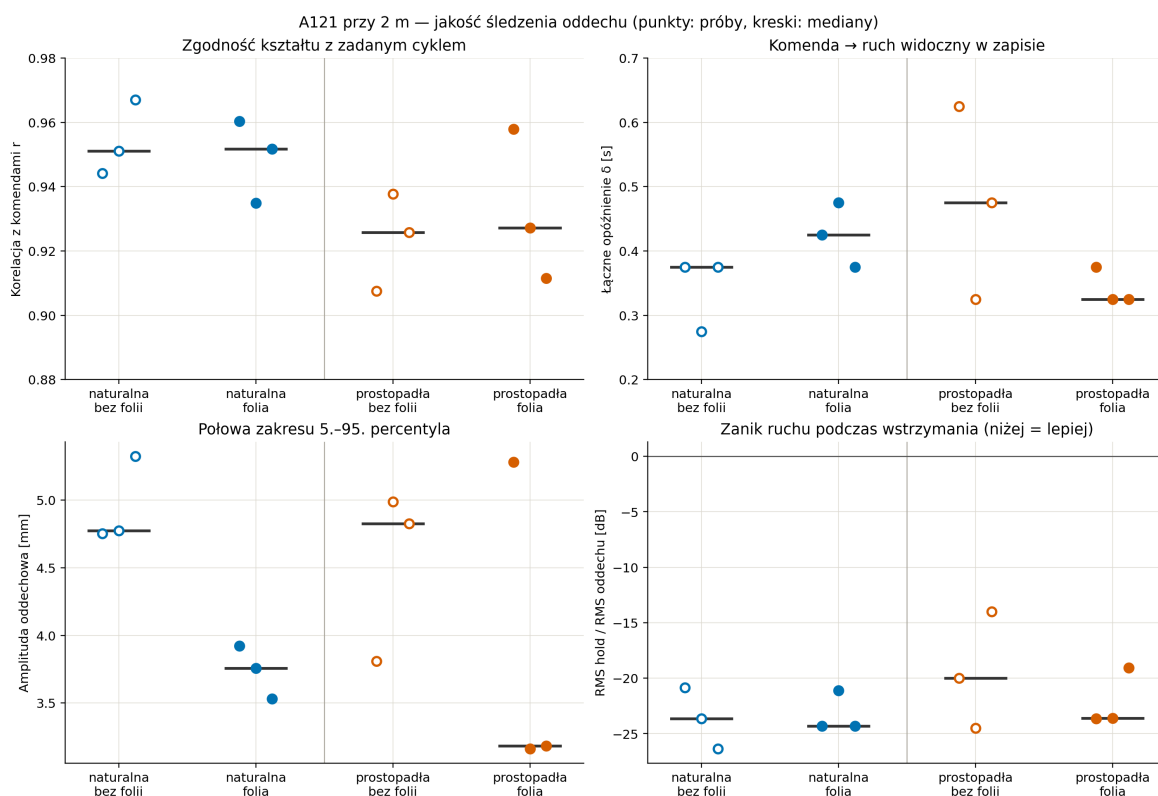
Kąt padania zdominował amplitudę echa. Po sparowaniu po numerze powtórzenia przejście z ustawienia naturalnego do prawie prostopadłego zwiększało amplitudę o medianę 11,06 dB bez folii i 11,62 dB z folią, czyli odpowiednio około 3,6 i 3,8 raza w skali amplitudowej IQ. Wynik nie ogranicza się do wysokości piku: mediana σ_d zmalała z około 5,3 cm w pozycji naturalnej do 1,1 cm do 1,3 cm w pozycji prostopadłej. Właściwe skierowanie wąskiej wiązki dawało zatem silniejsze i stabilniej zlokalizowane echo.

Dominująca bramka przesunęła się jednocześnie z około 2,01 m do 1,84 m do 1,87 m. Dystans z A121 nie jest tym samym pomiarem co odczyt dalekomierza do zaznaczonego punktu: po zmianie osi radaru maksimum może pochodzić z innego fragmentu zakrzywionego tułowia, a bezwzględne położenie bramki zależy też od profilu czujnika. Z tego powodu wzrostu o 11 dB nie należy przypisywać wyłącznie idealnemu prawu odbicia od tej samej płaskiej powierzchni. Jest to łączny, lecz praktycznie istotny efekt poprawnego wycelowania stanowiska.



Rysunek 11.10: Zmiana medianowej amplitudy echa po sparowaniu warunków po numerze powtórzenia. Lewy panel pokazuje efekt ustawienia prostopadłego względem naturalnego, prawy — efekt folii względem braku folii. Każdy punkt jest jednym powtórzeniem, kreska jego medianą dla danej geometrii lub stanu folii. Kąt daje duży efekt o zgodnym znaku; niewielki efekt folii zmienia znak między geometriami.

Folia nie dała powtarzalnego wzmocnienia. W pozycji naturalnej parowane zmiany amplitudy wyniosły +1,71, -1,28 i +1,68 dB (mediana +1,68 dB). W ustawieniu prawie prostopadłym, w którym powrót zwierciadlany powinien najbardziej sprzyjać metalowej łacie, wszystkie trzy zmiany były ujemne: -2,77, -0,72 i -0,78 dB (mediana -0,78 dB). Nie ma więc zgodnego efektu folii między dwiema geometriami. Ponieważ cały blok z folią poprzedzał blok bez folii, nie można utożsamiać małych różnic z czystym skutkiem materiału; można natomiast odrzucić praktycznie duże, jednoznaczne wzmocnienie oczekiwane od reflektora.



Rysunek 11.11: Metryki sygnału oddechowego przy 2 m; punkty oznaczają próby, kreski mediany, wypełnienie punktu folię, a pusty punkt jej brak. Korelacja dotyczy trójkątnego wzorca po korekcie δ . Amplituda jest miarą głębokości zarejestrowanego oddechu, nie siły echa. W prawym dolnym panelu bardziej ujemna wartość oznacza silniejszy zanik ruchu podczas wstrzymania.

Oddech był użyteczny we wszystkich 12 próbach. Korelacja ze wzorcem po korekcie opóźnienia wynosiła od 0,908 do 0,967. Częstość wyznaczona z odstępów między maksimami mieściła się w zakresie 11,86–12,10 oddechów/min, bardzo blisko zadanych 12 oddechów/min. Amplituda radialnego ruchu oddechowego wynosiła 3,16 mm do 5,32 mm. W środkowych 9 s wstrzymania RMS w paśmie oddechowym malał o 14,0 dB do 26,3 dB, czyli od około 5 do 21 razy w skali amplitudy. Zanik jest widoczny w każdej próbie, a trzysekundowe marginesy od granic wstrzymania ograniczają wpływ reakcji badanego i dzwonienia filtru wokół gwałtownej zmiany ruchu.

Większe echo nie przełożyło się wprost na większą zgodność faz oddechu. Mediany r wynosiły 0,951–0,952 w pozycji naturalnej i 0,926–0,927 w prostopadłej, mimo około czterokrotnie większej amplitudy IQ w drugiej geometrii. Przy zaledwie trzech powtórzeniach nie jest to dowód przewagi pozycji naturalnej, lecz potwierdzenie wcześniejszej obserwacji: po przekroczeniu progu użyteczności siła echa i wierność przebiegu są różnymi cechami.

W zapisanym strumieniu aplikacja referencyjna A121 podawała mediany 11,41–

12,12 oddechów/min; niezerowy wynik był dostępny w 54,8–83,2% ramek, co obejmuje czas początkowego ustalania celu i celowe wstrzymanie. Dla próby P0, powtórzenie 2, podsumowanie wykonane po zakończeniu zapisało 0 BPM, ponieważ ostatnie ramki przeszły do stanu DETERMINE_DISTANCE_ESTIMATE. Nie oznaczało to utraty oddechu: mediana wartości zapisanych wcześniej wynosiła 11,82 oddechów/min, korelacja offline 0,938, a częstość z ekstremów 11,98 oddechów/min. Przypadek pokazuje, że pojedynczy stan końcowy aplikacji nie powinien zastępować analizy całego przebiegu.

11.7.4 Wnioski z retestu

1. A121 z soczewką hiperboliczną rejestrował sterowany oddech i jego zatrzymanie z dystansu 2 m we wszystkich czterech warunkach.
2. Prawie prostopadłe ustawienie zwiększało echo o około 11 dB i stabilizowało położenie pików. Dokładne wycelowanie radaru jest zatem ważniejsze niż dodanie niewielkiej metalowej łaty.
3. Nie wykazano użytecznego wzmocnienia przez folię ani przy naturalnym, ani przy prawie prostopadłym padaniu. Wniosek o małym efekcie jest zgodny z testem 0,5 m do 1,0 m.

Rozdział 12

Sieci neuronowe do analizy faz oddechu

[**TODO: Rozdział jeszcze nie zrealizowany — kluczowa część pracy, do wykonania. Poniżej planowana struktura; zarezerwowano dużo miejsca.**]

12.1 Sformułowanie zadania

Miejsce zarezerwowane: Klasyfikacja faz cyklu oddechowego (wdech / wydech / pauza) z sygnału fazowego radaru A121. Alternatywnie: regresja fazy cyklu lub detekcja zdarzeń oddechowych.

12.2 Zbiór danych i anotacja

Miejsce zarezerwowane: Wykorzystanie zgromadzonej bazy nagrań (nagrania sterowane i całonocne). Istniejący moduł `a121_breaths` realizuje automatyczną wstępną anotację oddechów — opisać jej zasadę i sposób weryfikacji ręcznej. Podział na zbiór uczący / walidacyjny / testowy (rozłączny względem nagrań).

12.3 Architektura modelu

Miejsce zarezerwowane: Proponowane architektury: 1D-CNN na oknach sygnału, sieć rekurencyjna (LSTM/GRU), ewentualnie model hybrydowy. Wejście: przefiltrowany sygnał fazowy i/lub spektrogram. Uzasadnienie wyboru.

12.4 Uczenie i metryki

Miejsce zarezerwowane: Funkcja straty, augmentacja danych, walidacja krzyżowa po nagraniach. Metryki: dokładność klasyfikacji faz, F1, błąd wyznaczenia momentów przejścia.

12.5 Wyniki

Miejsce zarezerwowane: Tabele i wykresy wyników; porównanie z metodą klasyczną (baseline oparty na detekcji pików z rozdziału 10).

12.6 Dyskusja

Miejsce zarezerwowane: Ograniczenia (jeden badany, ograniczona liczba nagrań), możliwości uogólnienia, potencjał zastosowania w czasie rzeczywistym.

Część III

Część eksperymentalna: zastosowanie systemu

Rozdział 13

Całonocny monitoring snu

13.1 Cel badania

Docelowym zastosowaniem zbudowanego systemu jest bezkontaktowy monitoring snu. W tej części radar A121 wykorzystano do rejestracji pełnych nocy, a uzyskane przebiegi tętna, oddechu oraz oszacowane fazy snu porównano z danymi z zegarka Garmin Fenix 7, który służył jako konsumencki punkt odniesienia, a nie jako wzorzec kliniczny.

13.2 Metodyka pomiarów

Zarejestrowano serię nagrań całonocnych w dwóch ustawieniach stanowiska. Równolegle badany nosił zegarek Garmin Fenix 7, z którego — jeżeli eksport zachował się dla danej nocy — odczytywano tętno, częstość oddechu i fazy snu w formacie FIT. Pierwsze trzy nagrania służyły pilotażowemu porównaniu przesłan:

- noc 1 — soczewka plano-convex,
- noc 2 — soczewka FZP,
- noc 3 — płaska pokrywa (efektywnie brak soczewki); nagranie zostało przerwane, przez co jest krótsze.

W nocach 1 i 2 radar znajdował się przy bocznej krawędzi łóżka, około 10 cm nad górną powierzchnią materaca, a jego oś była równoległa do podłoża. Takie ustawienie jest zbliżone do prostopadłego względem klatki tylko wtedy, gdy badany leży na boku i pozostaje na wysokości czujnika. Po obrocie na plecy, przesunięciu w głąb łóżka albo zmianie ułożenia tułowia oś przestaje trafiać w ten sam fragment klatki. Jest to szczególnie niekorzystne dla węższych wiązek soczewek skupiających i wyjaśnia, dlaczego początkowo poprawne wycelowanie nie gwarantowało dobrej jakości przez całą noc.

W trzech późniejszych, pełnych nagraniach z 13, 15 i 16 czerwca zastosowano płaską pokrywę oraz ustawienie nad łóżkiem pokazane na rys. 13.1. Statyw Manfrotto stał obok łóżka, a poziomy wysięgnik wprowadzał czujnik nad tułów. Głowicę skierowano w dół, w przybliżeniu pod kątem 45° względem powierzchni materaca, na środkową część klatki piersiowej. Mediany odległości celu śledzonego przez A121 wynosiły odpowiednio 0,30 m, 0,37 m i 0,39 m. Stanowisko opisano więc jako dystans około 0,4 m, zmienny wraz z pozycją ciała i ułożeniem pościeli, a nie jako odległość wyznaczoną z dokładnością dalmierza. Szerokie pole widzenia płaskiej pokrywy obejmowało większą część tułowia i lepiej tolerowało nocne przesunięcia niż ustawienie przy krawędzi łóżka.



Rysunek 13.1: Stanowisko do pełnych pomiarów nocnych z płaską pokrywą. Wysięgnik statywu wprowadza czujnik nad łóżko, a regulowana głowica kieruje jego oś ukośnie na tułów. Na podstawie śledzonej bramki A121 efektywny dystans do dominującego celu wynosił około 0,4 m.

Osobno wykonano późniejszą noc z soczewką hiperboliczną i większego dystansu. Mediana śledzonej odległości wynosiła 1,62 m, lecz oś radaru była odchylona od normalnej do klatki o ponad 60° . Echo padało zatem pod bardzo niekorzystnym kątem i wynik oddechowy był niestabilny; nagranie wyłączono z porównania fizjologicznego. Nie jest to dowód ograniczenia soczewki, tylko nieudanej geometrii stanowiska.

Czas ramek A121 zapisywano jako czas systemowy komputera, a znaczniki FIT przeliczano na tę samą strefę lokalną. Wartości Garmina przypisywano do okien radaru metodą najbliższego znacznika z tolerancją 2 min. Nie była to synchronizacja sprzętowa; wystarczała do trendów w kroku 30 s, lecz nie pozwala analizować opóźnień pojedynczego uderzenia serca.

13.3 Estymacja tętna i oddechu przez całą noc

Algorytm z rozdziału 10 operuje na oknie kilkudziesięciu sekund. Nocne nagranie trwa jednak 7–9 godzin i zawiera długie okresy ruchu, przewracania się oraz nieobecności. Analizę nocną realizuje więc nakładka (`tools/analyze_a121_sleep_vitals_gated.py`), która przesuwaa 60 s okno analizy z krokiem 30 s i dla każdego okna wywołuje analizator parametrów życiowych, budując trend HR/RR.

Kluczowe jest **bramkowanie okien**. Każdą ramkę klasyfikuje się na podstawie stanu detektora obecności czujnika jako *spoczynek* (`still`), *ruch* (`movement`) lub *brak obecności* (`no_presence`). Dla okna liczy się frakcje tych stanów i odrzuca okno, gdy zachodzi którykolwiek z warunków:

- ostatnia ramka okna to ruch lub brak obecności (estymata byłaby publikowana w momencie, gdy badanego już nie ma w więzce),
- frakcja braku obecności przekracza 0,05,
- okno zawiera ciągły ruch dłuższy niż 30 s,
- frakcja spoczynku spada poniżej 0,65.

Dodatkowo estymatę tętna przyjmuje się tylko przy pewności ≥ 5 i w zakresie fizjologicznym 42 ud/min do 120 ud/min. Krótkie przerwy ruchowe (poniżej 30 s) są sklejane, aby pojedyncze drgnięcie nie rozbijało ciągłego odcinka snu na fragmenty.

Efektom jest szereg czasowy z krokiem 30 s, zawierający tętno, częstość oddechu, frakcje stanów oraz dominujący stan okna — to on jest wejściem klasyfikatora faz snu. Duża część okien nocy jest odrzucana i to jest zachowanie pożądane: lepiej nie podać wartości niż podać wartość wziętą z artefaktu ruchowego.

13.4 Algorytm klasyfikacji faz snu

Na podstawie trendu z sekcji 13.3 zbudowano heurystyczny klasyfikator faz snu (moduł `a121_sleep`), rozróżniający czuwanie, sen lekki, sen głęboki i fazę REM. Nie jest to model uczony — to zestaw reguł opartych na znanych korelatkach fizjologicznych, które są dostępne radarowi: tętno, oddech, ich zmienność oraz ruch ciała.

Cechy pochodne. Z trendu wyznacza się medianę kroczącą tętna i oddechu w oknie 5 min ($\overline{HR}$, $\overline{RR}$) oraz ich odchylenie standardowe w oknie 10 min (s_{HR} , s_{RR} — miary zmienności), a także wygładzoną frakcję ruchu. Progi decyzyjne *nie* są stałymi bezwzględными, lecz percentylami wyznaczanymi **indywidualnie dla danej nocy** — inaczej klasyfikator nie przenosiłby się między osobami ani między nocami:

- HR_{deep} — mediana tętna podczas snu (percentyl 50),
- s_{HR}^{70} — percentyl 70 zmienności tętna,
- s_{RR}^{60} , s_{RR}^{75} — percentyle 60 i 75 zmienności oddechu,
- HR_{base} , IQR_{HR} — mediana i rozstęp międzykwartylowy tętna podczas snu.

Wykrycie zaśnięcia i przebudzenia. Za moment zaśnięcia przyjmuje się początek pierwszego okresu, w którym przez kolejne 30 min utrzymuje się (w co najmniej 80% okien) spoczynek: frakcja spoczynku $\geq 0,80$, frakcja ruchu $\leq 0,20$, brak obecności $\leq 0,05$ oraz dostępna estymata tętna lub oddechu. Jeżeli wewnątrz tego okresu wystąpi jeszcze silny ruch, zaśnięcie przesuwają się za jego koniec. Przebudzenie wykrywa się tylko wtedy, gdy nagranie kończy się co najmniej 20 min ciągłym okresem ruchu/nieobecności; w przeciwnym razie za moment wybudzenia przyjmuje się koniec nagrania — to jedyna uczciwa interpretacja, bo radar nie ma innej przesłanki, że badany wstał.

Reguły decyzyjne. Dla każdego okna wewnątrz okresu snu:

- **Czuwanie** (arousal): frakcja braku obecności $> 0,20$ lub frakcja ruchu $> 0,35$, albo stan okna wskazuje ruch/nieobecność.
- **Sen głęboki:** co najmniej 20 min od zaśnięcia, ruch $< 0,10$, tętno $\overline{HR} \leq HR_{\text{deep}}$ (poniżej mediany nocnej), niska zmienność oddechu $s_{RR} \leq s_{RR}^{60}$ oraz pierwsze 70% nocy. Odzwierciedla to fizjologię: w śnie wolnofalowym tętno spada, a oddech staje się regularny; sen głęboki koncentruje się w pierwszej połowie nocy.
- **REM:** co najmniej 75 min od zaśnięcia i po 18% nocy, mały ruch ($< 0,15$), ale *podwyższona zmienność* — $s_{HR} \geq s_{HR}^{70}$ lub $s_{RR} \geq s_{RR}^{75}$. W REM występuje atonia mięśni (ciało nieruchome), lecz oddech i tętno stają się nieregularne; to właśnie ta kombinacja odróżnia REM od snu głębokiego, w którym ciało również jest nieruchome.
- **Sen lekki** — przypadek domyślny.

Gdy reguły snu głębokiego i REM zostaną spełnione jednocześnie, w drugiej połowie nocy (po 55% czasu snu) pierwszeństwo ma REM.

Postprzetwarzanie. Krótkie „wysepki” faz nie-czuwania krótsze niż 4 min są scalane z otoczeniem, aby hipnogram był czytelny; epizody czuwania *nie* są scalane — usunięcie ich zatarłoby dowody wybudzeń. Pierwsza wersja reguł dopuszczała również bezpośrednie przejścia REM ↔ sen głęboki. Ponieważ przy rozdzielczości 30 s bezpieczniejszą interpretacją jest przejście przez lżejsze stadium, do wersji końcowej dodano jawne ograniczenie strukturalne: pierwsze 4 min fazy docelowej po takim skoku oznacza się jako sen lekki. Korekta nie korzysta z etykiet Garmina ani nie zmienia progów HR/RR; każde zmienione okno zachowuje osobną flagę `radar_direct_transition_bridge_to_light` i jest zaznaczone na hipnogramach jasnym żółtym tłem. Osobno wykryto specyficzny przypadek: *spokojne, ale pofragmentowane leżenie nad ranem* (np. leżenie w łóżku z telefonem po głównym epizodzie snu). Mały ruch ciała imituje wtedy REM, dlatego w ostatnich 12% okresu snu, jeśli utrzymuje się wysoka nieruchomość przy powtarzających się drobnych sygnałach ruchu, kandydaci REM są degradowani do snu lekkiego.

Status wyniku: estymacja, nie pomiar. Trzeba postawić sprawę otwarcie: **wyznaczonych faz snu nie da się w tej pracy zweryfikować.** Jedynym dostępnym odniesieniem był zegarek Garmin Fenix 7, a on *sam również nie jest metodą referencyjną* — to urządzenie konsumenckie, które fazy snu szacuje heurystycznie z tętna, HRV, ruchu i (w nowszych modelach) pulsoksymetrii. Złotym standardem pozostaje polisomnografia (EEG, EOG, EMG), której w tym projekcie nie było. Rozbieżność radar–Garmin *nie dowodzi zatem błędu radaru*: mówi tylko tyle, że dwie heurystyki oparte na sygnałach zastępczych dały różne wyniki, i z samego porównania nie wynika, która z nich jest bliżej prawdy. Ani sen głęboki, ani REM nie są przez ten system *mierzone* — są *estymowane* regułami zebranymi wyżej, opartymi na znanych korelatach fizjologicznych (spadek i stabilizacja tętna w śnie wolnofalowym, wzrost nieregularności tętna i oddechu przy atonii mięśniowej w REM). Wszystkie liczby dotyczące faz snu w dalszej części należy czytać z tym zastrzeżeniem.

Miejsce zarezerwowane: Miejsce na przegląd literatury o dokładności faz snu w urządzeniach konsumenckich: badania walidacyjne Garmina (i pokrewnych: Fitbit, Oura, Withings) względem polisomnografii — typowo wysoka czułość detekcji snu jako takiego (rzędu 0,9), ale znacznie słabsza zgodność stadiów, w szczególności notoryczne mylenie snu głębokiego z lekkim i zawyżanie/zaniżanie REM; podać raportowane wartości κ Cohena i dokładność 4-klasową. To jest uzasadnienie, dlaczego Garmin jest w tej pracy traktowany jako punkt odniesienia, a nie jako prawda.

13.5 Ocena jakości snu (*sleep score*)

Czym ta liczba jest, a czym nie jest. Warto zacząć od zastrzeżenia, które rzadko pada w materiałach producentów: *ocena snu* (*sleep score*) w skali 0–100 jest **metryką wymyśloną przez producentów urządzeń**, a nie wielkością fizjologiczną ani kliniczną. Nie odpowiada jej żadna jednostka, żadne badanie referencyjne i żadna definicja w medycynie snu — polisomnografia nie zwraca „74 punktów”. Każdy producent (Garmin, Fitbit, Oura, Withings) liczy ją inaczej i z innych składowych, a konkretne wzory są tajemnicą handlową; ta sama noc oceniona dwoma urządzeniami potrafi dać istotnie różne wyniki. **Sama w sobie liczba ta nic nie znaczy** — jest co najwyżej wygodnym skrótem, który agreguje kilka mierzalnych cech nocy (długość, ciągłość, proporcje faz, spokój, parametry vitalne) w jedną wartość porównywalną ze *samą sobą* z nocy na noc.

Mimo to metryka ta jest powszechnie oczekiwana przez użytkownika, dlatego — wyłącznie ze względu na jej popularność i porównywalność z zegarkiem konsumenci — opracowano algorytm, który *z grubsza odtwarza zachowanie* oceny Garmina. Odtworzono *zachowanie*, nie wzór: wzór Garmina nie jest publiczny. Charakterystyczne dla ocen konsumenckich (i odtworzone tutaj) są dwie cechy: dominująca rola długości snu oraz nasycanie się składowych — „wystarczająco dobra” wartość cechy daje komplet punktów, a pogorszenie karane jest liniowo.

Konstrukcja. Ocena jest sumą pięciu składowych, ograniczoną z góry pułapem zależnym od całkowitego czasu snu T (w minutach):

$$\text{score} = \min(D + C + B + R + V, \text{cap}(T)), \quad D + C + B + R + V \leq 100. \quad (13.1)$$

Wszystkie składowe zbudowano z funkcji nasycającej $\sigma(x) = \min(\max(x, 0), 1)$ (obcięcie do przedziału $[0, 1]$), co gwarantuje ograniczoność i monotoniczność każdego

członu:

$$D = 30 \sigma \left(\frac{T}{480} \right) \cdot \begin{cases} 1, & T \leq 540, \\ \sigma \left(1 - \frac{T - 540}{180} \right), & T > 540, \end{cases} \quad (13.2)$$

$$C = 15 \sigma \left(\frac{\eta - 0,75}{0,18} \right) + 3 \sigma \left(1 - \frac{T_{\text{awake}}}{60} \right) + 2 \sigma \left(1 - \frac{n_{\text{aw}}}{4} \right), \quad (13.3)$$

$$B = 10 Q(p_{\text{deep}}; 4, 13, 23, 33 \%) + 10 Q(p_{\text{rem}}; 8, 18, 27, 40 \%), \quad (13.4)$$

$$R = 8 \sigma \left(1 - \frac{\overline{m}}{0,08} \right) + 3 \sigma \left(1 - \frac{\overline{u}}{0,03} \right) + 4 \sigma \left(1 - \frac{n_{\text{aw}}}{6} \right), \quad (13.5)$$

$$V = 7 \sigma \left(1 - \frac{[\widetilde{HR} - 55]_+}{25} \right) + 4 \sigma \left(1 - \frac{[s_{HR} - 4]_+}{8} \right) + 4 \sigma \left(1 - \frac{[s_{RR} - 1,2]_+}{3} \right), \quad (13.6)$$

gdzie η — efektywność snu (sen/okres snu), T_{awake} — minuty czuwania, n_{aw} — liczba wybudzeń dłuższych niż 1 min na godzinę, $\overline{m}$, $\overline{u}$ — średnia frakcja ruchu i nieobecności, $\widetilde{HR}$ — mediana tętna we śnie, s_{HR} , s_{RR} — odchylenia standardowe tętna i oddechu, $[x]_+ = \max(x, 0)$, a p_{deep} , p_{rem} — procentowe udziały faz. Sens progów jest następujący: pełne 30 punktów za długość otrzymuje się dopiero przy 8 h snu (kara zaczyna się powyżej 9 h); efektywność 93 % wysyca składową ciągłości; mediana tętna do 55 bpm i odchylenie tętna do 4 bpm dają komplet punktów za regenerację.

Proporcje faz ocenia funkcja plateau Q — trapez, który daje maksimum w przedziale uznawanym za prawidłowy i maleje liniowo *po obu stronach*, karząc zarówno niedobór, jak i nadmiar danej fazy:

$$Q(p; a, b, c, d) = \begin{cases} 0, & p \leq a \text{ lub } p \geq d, \\ \frac{p - a}{b - a}, & a < p < b, \\ 1, & b \leq p \leq c, \\ \frac{d - p}{d - c}, & c < p < d. \end{cases} \quad (13.7)$$

Dla snu głębokiego plateau przyjęto na 13–23%, dla REM na 18–27% czasu snu.

Kluczowy jest jednak nie sam wzór, lecz *pułap* $\text{cap}(T)$, bo to on — podobnie jak

w zegarkach konsumenckich — w praktyce decyduje o ocenie:

$$\text{cap}(T) = \begin{cases} 30 + 30 \sigma\left(\frac{T}{240}\right), & T < 240 \text{ min (4 h)}, \\ 60 + 20 \sigma\left(\frac{T-240}{180}\right), & 240 \text{ min} \leq T < 420 \text{ min (7 h)}, \\ 80 + 20 \sigma\left(\frac{T-420}{60}\right), & 420 \text{ min} \leq T < 480 \text{ min}, \\ 100, & T \geq 480 \text{ min (8 h)}. \end{cases} \quad (13.8)$$

Krótką noc *nie może* więc zostać oceniona wysoko, choćby była idealnie spokojna i ciągła — poniżej 4 h snu maksimum to 60 punktów. Widać to w zebranych danych: dla wszystkich analizowanych nocy suma składowych (raw score) była wyższa od oceny końcowej, a ograniczał ją właśnie pułap czasu (np. noc 1: składowe 83,8 pkt, pułap 73,8 pkt → ocena 74). Innymi słowy: *ocena mierzy głównie to, ile się spało*, a pozostałe składowe jedynie ją modułują — co jest zarazem trafną obserwacją o tym, jak działają oceny snu w urządzeniach komercyjnych.

Tabela 13.1: Składowe punktowej oceny snu (`score_radar_sleep`). Maksimum sumy wynosi 100 punktów, a dodatkowo całość ogranicza pułap zależny od długości snu, wzór (13.8).

Składowa	Co ocenia	Maks.
Długość D	czas snu względem 8 h; kara za sen > 9 h	30
Ciągłość C	efektywność snu, minuty czuwania, liczba wybudzeń/h	20
Proporcje faz B	udział snu głębokiego (13–23%) i REM (18–27%)	20
Spokój R	średnia frakcja ruchu i nieobecności, wybudzenia	15
Regeneracja V	mediana tętna, stabilność tętna i oddechu	15

Etykieta słowna przypisywana jest progowo: ≥ 90 — „doskonała”, ≥ 80 — „dobra”, ≥ 60 — „przeciętna”, poniżej — „słaba”. Tętno spoczynkowe szacuje się jako 10. percentyl tętna w oknach snu o znikomym ruchu.

Czy to rzeczywiście „matchuje” Garmina? Dla nocy 1 udało się odzyskać pełny eksport oceny z aplikacji Garmin Connect (`Sleep.csv`), co pozwala zestawiać obie metryki bezpośrednio (tab. 13.2). Zgodność samej oceny jest uderzająca: **74 punkty w obu przypadkach** i identyczna etykieta jakości, przy niezależnie wyznaczonym czasie snu różniącym się o 7 minut. Zgadza się też tętno spoczynkowe — 52,7 bpm z radaru wobec 51 bpm z zegarka — co zamyka pytanie postawione przy opisie estymatora tętna spoczynkowego.

Tabela 13.2: Noc 1 — zestawienie wyniku własnego z *dwoma* źródłami danych z tego samego zegarka: surowym strumieniem SLEEP_DATA z pliku FIT (to jego użycie w tab. 13.6) oraz podsumowaniem pokazywanym użytkownikowi w aplikacji Garmin Connect. Oba pochodzą z tej samej nocy i tego samego urządzenia.

	Radar (ta praca)	Garmin (FIT)	Garmin (Connect)
Ocena snu [pkt]	74	—	74
Etykieta jakości	<i>Fair</i>	—	<i>Fair</i>
Czas snu [min]	364,5	326,0	357,0
Sen głęboki [min]	70,5	57,0	82,0
Sen lekki [min]	224,5	222,0	159,0
REM [min]	69,5	47,0	116,0
Czuwanie [min]	24,0	40,0	24,0
Sen głęboki [% snu]	19,3	17,5	23,0
REM [% snu]	19,1	14,4	32,5
Tętno spoczynkowe [bpm]	52,7	—	51

Dwa Garminy, jedna noc. Tabela 13.2 ujawnia jednak coś, co jest w tej pracy ważniejsze od samej zgodności oceny: **dwa eksporty z tego samego zegarka, dotyczące tej samej nocy, podają istotnie różne fazy snu.** Surowy strumień FIT przypisuje REM 47 minut, a aplikacja — 116 minut; sen głęboki odpowiednio 57 i 82 minuty. Różnica w REM jest *dwuipółkrotna*. Nie jest to błąd odczytu: strumień SLEEP_DATA zawiera znaczniki zmian stadium rejestrowane na urządzeniu, a aplikacja pokazuje wynik po własnym (niejawnym) postprzetwarzaniu w chmurze.

Wniosek jest niewygodny, ale nieunikniony: *Garmin nie jest wzorcem, skoro nie zgadza się sam ze sobą*. Zależnie od tego, który eksport przyjmujemy za odniesienie, radar raz *zawyża* sen głęboki (o 13,5 min względem FIT), a raz *zaniża* (o 11,5 min względem aplikacji) — przy dokładnie tych samych danych radarowych. To najmocniejszy dostępny w tej pracy argument za tym, że rozbieżności faz snu z sekcji 13.9 nie wolno interpretować jako „błędu radaru”.

Sama zgodność oceny (74 vs 74) też nie jest dowodem poprawności — i warto rozumieć, *dlaczego* wyszła tak dobrze. Ocena jest zdominowana przez czas snu (wzór (13.8)), a czas snu obie metody mierzą podobnie, bo obie wykrywają to samo: brak ruchu i spadek tętna. Rozjazd ujawnia się dopiero tam, gdzie czas snu nie decyduje — w proporcjach faz. **Zgodne oceny przy niezgodnych fazach** to dokładna ilustracja tezy tej sekcji: ocena snu jest agregatem o małej rozdzielczości informacyjnej. Jedna noc to zresztą anegdota, a nie walidacja.

[TODO: Uzasadnić progi literaturowo (odsetki faz snu u dorosłych).

Rozważyć krótki przegląd: jak liczą ocenę snu Garmin/Fitbit/Oura i dlaczego wyniki nie są porównywalne między producentami. Eksport Sleep.csv udało się odzyskać tylko dla nocy 1 — dla pozostałych nocy warto go dociągnąć z Garmin Connect i powtórzyć tabelę 13.2, żeby sprawdzić, czy rozjazd FIT vs Connect powtarza się co noc.]

13.6 Wyniki: podsumowanie radarowe

Tabela 13.3: Podsumowanie snu wyznaczone wyłącznie z radaru. Trzy ostatnie wiersze dotyczą pełnych nocy z płaską pokrywą i czujnikiem nad łóżkiem.

Nagranie / konfiguracja	Ocena	Sen całk. [min]	Efektywność [%]	Spocz. HR [bpm]	Jakość
1 (plano-convex, krawędź)	74	364,5	93,8	52,7	Przeciętna
2 (FZP, krawędź)	71	342,5	95,0	51,9	Przeciętna
3 (płaska, zapis przerwany)	49	154,0	85,8	50,8	Słaba
13.06 (płaska, nad łóżkiem)	93	485,0	97,1	49,7	Doskonała
15.06 (płaska, nad łóżkiem)	78	454,5	89,4	51,1	Przeciętna
16.06 (płaska, nad łóżkiem)	91	551,0	97,6	50,5	Doskonała

Noc 3 wypadła znacznie gorzej głównie dlatego, że nagranie zostało przerwane i jest krótkie — ocena została ograniczona przez czas snu. Oszacowane tętno spoczynkowe pozostało spójne między nocami (około 50–53 bpm). Trzy późniejsze pełne noce pokazują, że w ustawieniu nad łóżkiem z płaską pokrywą można powtarzalnie uzyskać wielogodzinne, w dużej części ciągle trendy radarowe. Nie potwierdza to jednak poprawności etykiet faz ani samo w sobie nie dowodzi przewagi tej przesłony: punktowa ocena rośnie przede wszystkim z długością i ciągłością zapisu.

13.7 Wyniki: porównanie tętna z Garmin Fenix 7

Tabela 13.4: Porównanie tętna (okna snu): radar vs Garmin Fenix 7.

Noc	Radar śr. [bpm]	Garmin śr. [bpm]	Obciążenie śr.	Obciążenie med.
1 (plano-convex)	55,5	57,4	−1,9	−1,8
2 (FZP)	55,1	58,3	−3,3	−2,4
3 (płaska)	53,8	53,6	+0,1	+1,3
13.06 (płaska, nad łóżkiem)	52,5	52,7	−0,1	+0,4

Zgodność tętna jest najważniejszym wynikiem praktycznym, ponieważ — w przeciwieństwie do surowej amplitudy — jest odporna na problem odbicia od krawędzi łóżka. Co ciekawe, noc z płaską pokrywą wypadła najlepiej, a obie noce z soczewką

zaniżały tętno. Nie dowodzi to wyższości płaskiej pokrywy, pokazuje natomiast, że przewaga w zysku anteny nie przekłada się automatycznie na lepszą zgodność fizjologiczną w danym ustawieniu. Wiarygodną hipotezą wyjaśniającą jest geometria pomiaru: soczewki skupiające zawężają obszar obserwacji, więc zmiana pozycji śpiącej osoby lub niedokładne utrzymanie osi radaru na klatce może usunąć właściwy reflektor z głównej wiązki. Płaska pokrywa obejmuje szerszy obszar i przy małych odległościach może być bardziej odporna na takie przesunięcie, mimo mniejszego zysku. Ponieważ każdy wariant soczewki badano innej nocy, zebrane dane nie pozwalają oddzielić wpływu soczewki od wpływu ułożenia ciała i mocowania; jest to interpretacja, a nie wykazany związek przyczynowy. Pełna noc z 13 czerwca, już w ustawieniu nad łóżkiem, również miała praktycznie zerowe średnie obciążenie HR względem Garmina. Dla nocy z 15 i 16 czerwca eksport zegarka nie był dostępny, dlatego nie dopisano im pozornej „referencji” i pokazano jedynie przebiegi radarowe.

13.8 Wyniki: porównanie częstości oddechu

Tabela 13.5: Porównanie częstości oddechu (okna snu): radar vs Garmin Fenix 7.

Noc	Radar śr. [odd./min]	Garmin śr.	Obciążenie śr.	Obciążenie med.
1 (plano-convex)	13,6	14,0	−0,4	−0,2
2 (FZP)	14,6	14,2	+0,4	+0,5
3 (płaska)	14,3	14,0	+0,3	+0,2
13.06 (płaska, nad łóżkiem)	14,5	13,7	+0,7	+0,6

Zgodność częstości oddechu okazała się lepsza niż zgodność tętna — średnie obciążenie w pierwszych trzech nocach nie przekraczało pół oddechu na minutę, a w pełnej nocy nad łóżkiem wyniosło około 0,7 oddechu/min. Jest to najbardziej stabilny wynik badania nocnego, choć nadal stanowi porównanie z urządzeniem konsumenckim, a nie walidację kliniczną.

13.9 Wyniki: porównanie faz snu

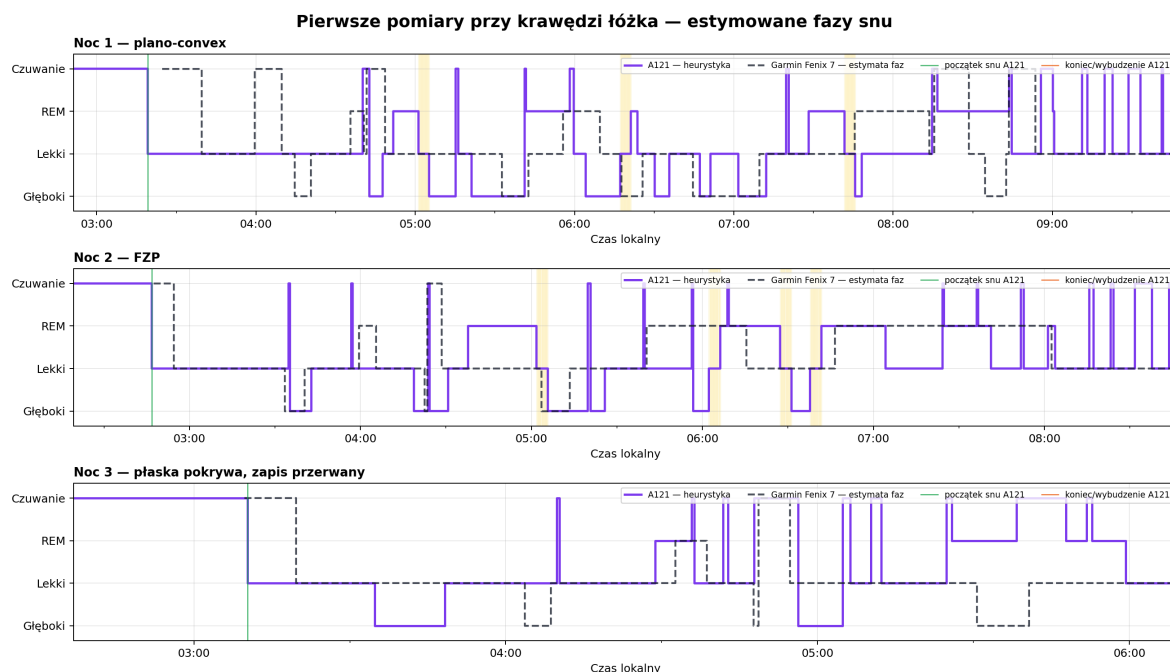
Zgodnie z zastrzeżeniem z sekcji 13.4: poniższe zestawienie jest *porównaniem dwóch estymat*, a nie oceną dokładności względem prawdy. Garmin nie jest tu wzorcem — fazy snu szacuje własną, niejawną heurystyką, której zgodność ze stadiami polisomnograficznymi jest w literaturze umiarkowana. Różnica „radar — Garmin” mierzy więc rozjazd dwóch przybliżeń.

Tabela 13.6: Sumaryczny czas trwania faz snu. Różnica dodatnia oznacza, że radar przypisał danej fazie więcej czasu niż Garmin. Obie kolumny są estymatami — żadna z nich nie jest odniesieniem polisomnograficznym.

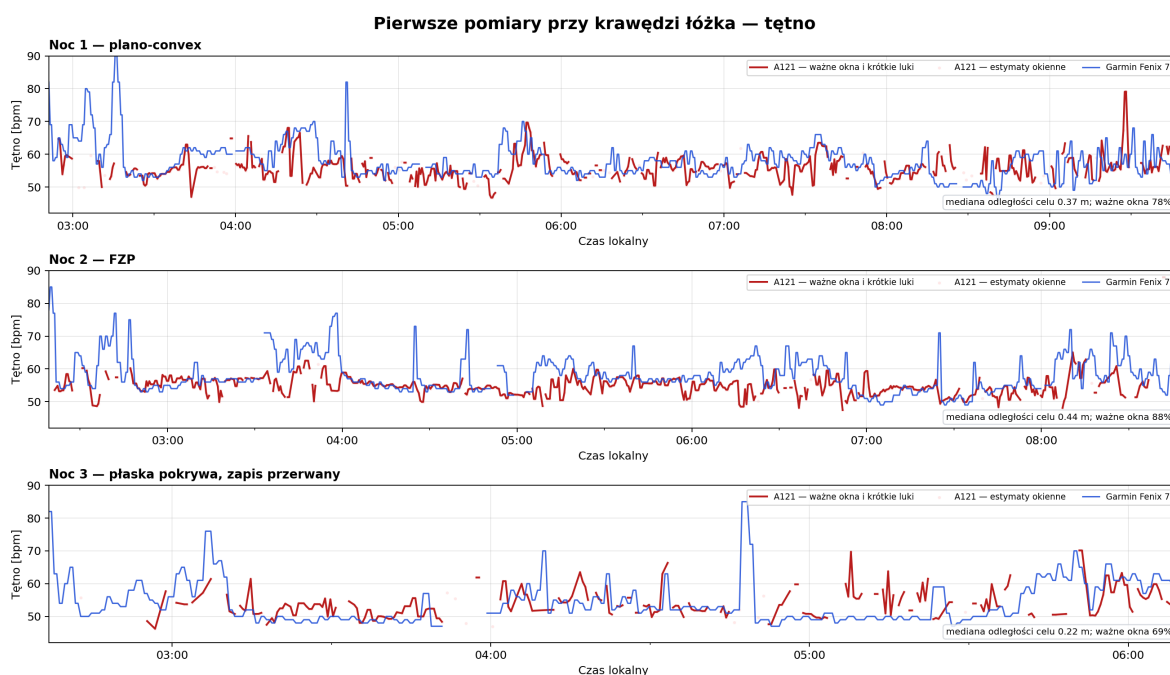
Noc	Źródło	Czuwanie [min]	Sen lekki [min]	Sen głęboki [min]	REM [min]
1	Radar	24,0	224,5	70,5	69,5
1	Garmin	40,0	222,0	57,0	47,0
1	Różnica	-16,0	+2,5	+13,5	+22,5
2	Radar	18,0	207,0	50,0	85,5
2	Garmin	5,0	211,0	18,0	117,0
2	Różnica	+13,0	-4,0	+32,0	-31,5

Względem strumienia FIT radar przypisywał więcej czasu fazie snu głębokiego (o 13,5 i 32 minuty). Wniosek ten trzeba jednak natychmiast osłabić: jak pokazano w tabeli 13.2, *drugi* eksport z tego samego zegarka (podsumowanie z aplikacji Garmin Connect) podaje dla nocy 1 sen głęboki 82 minuty — czyli *więcej* niż radar (70,5 min). Kierunek rozbieżności odwraca się więc w zależności od tego, który eksport Garmina uzna się za odniesienie, przy niezmiennych danych radarowych. Ostrożna konkluzja brzmi: radar i Garmin różnią się w proporcjach faz, ale dane nie pozwalają orzec, która heurystyka jest bliżej rzeczywistości.

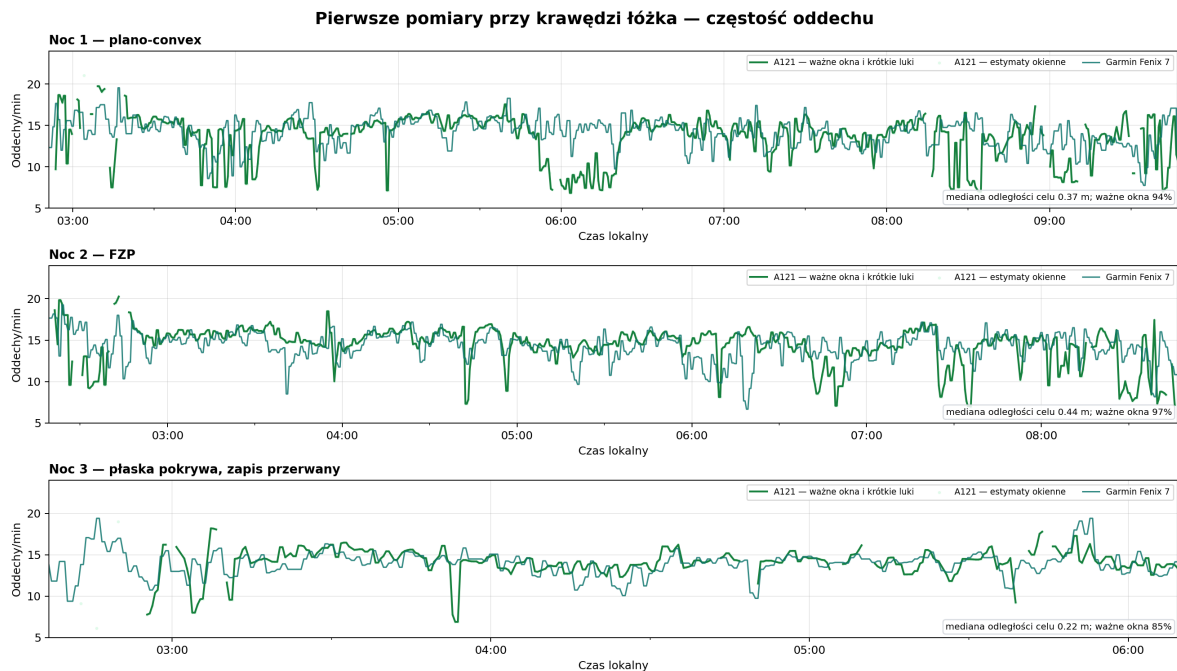
Istotna obserwacja diagnostyczna dotyczyła *struktury* hipnogramu. Pierwsza wersja klasyfikatora wykazała w obu nocach po dwa bezpośrednie przejścia REM → sen głęboki, podczas gdy Garmin nie wykazał żadnego. Zamiast dostrajać progi do zegarka, wprowadzono opisany wcześniej, niezależny od Garmina warunek przejścia przez sen lekki. W wyniku końcowym bezpośrednich przejść REM ↔ sen głęboki już nie ma; w nocy 1 przeniesiono do snu lekkiego łącznie 12 minut, a w nocy 2 — 16 minut. Jest to naprawa niespójności reguł, nie dowód poprawności pozostałych etykiet.



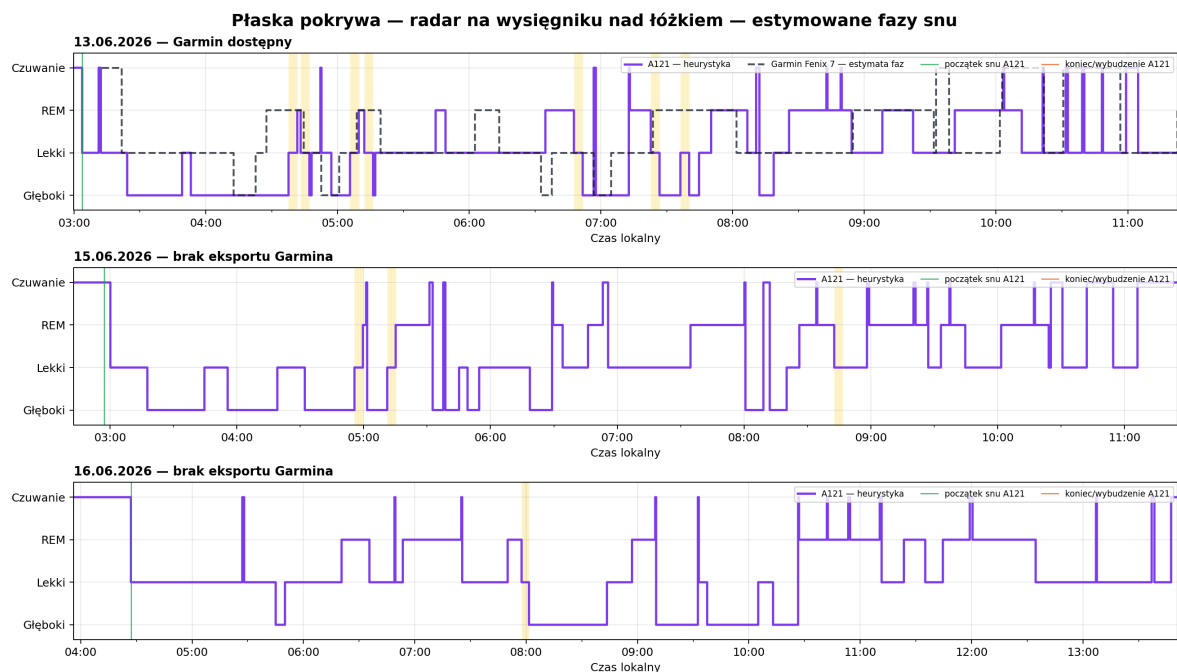
Rysunek 13.2: Estymowane fazy snu w pierwszych trzech nagraniach. Linia fioletowa oznacza wynik A121, przerywana — estymatę Garmina, a jasne żółte pola — okna, w których reguła strukturalna wstawiła sen lekki między REM i snem głębokim. Nocy 3 nie należy porównywać czasowo z pozostałymi, ponieważ zapis został przerwany.



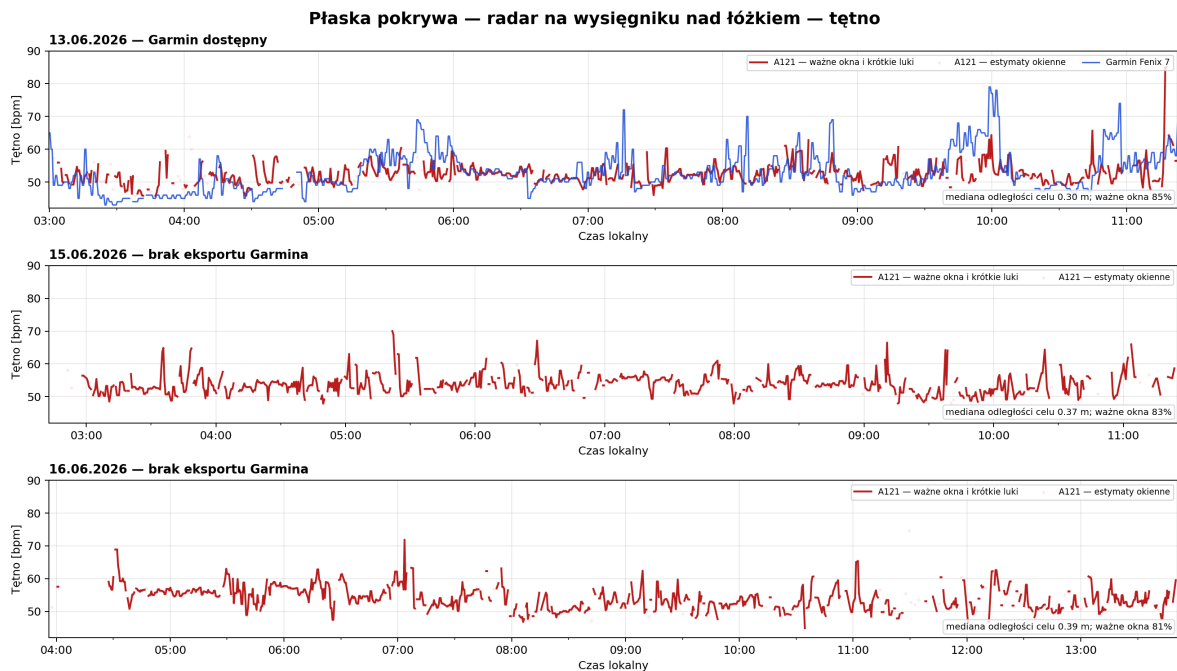
Rysunek 13.3: Tętno w pierwszych trzech nocach: A121 i Garmin Fenix 7. Linia A121 łączy wyłącznie ważne okna oraz krótkie przerwy ruchowe; długie luki pozostawiono celowo, aby nie sugerować ciągłości pomiaru tam, gdzie estymata została odrzucona.



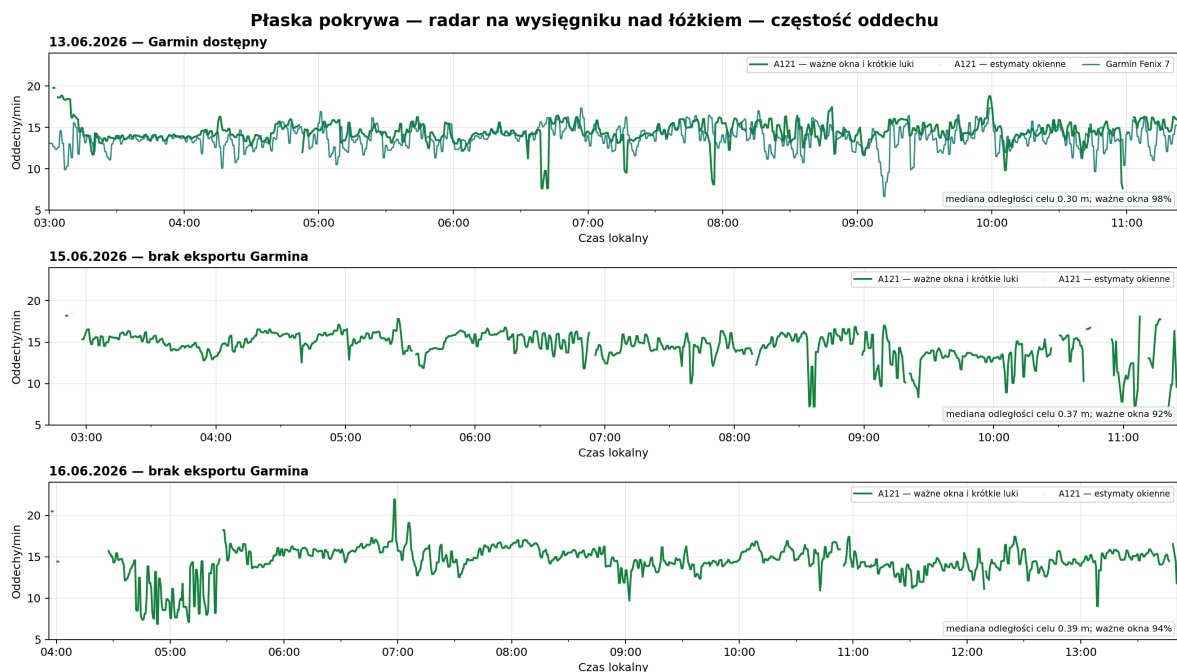
Rysunek 13.4: Częstość oddechu w pierwszych trzech nocach. Zgodność trendów jest wyraźnie lepsza niż dla tętna, zwłaszcza w spokojnych odcinkach nocy. Widoczne krótkie odchylenia i luki należy interpretować razem z odrzucaniem okien po ruchu, a nie jako pewne zmiany fizjologiczne.



Rysunek 13.5: Trzy pełne noce z płaską pokrywą i radarem na wysięgniku nad łóżkiem. Dla 13 czerwca dostępna jest estymata faz Garmina; dwa pozostałe panele są radarowe i nie powinny być interpretowane jako zweryfikowane stadia snu.



Rysunek 13.6: Tętno w trzech pełnych nocach z ustawieniem nad łóżkiem. Mediana śledzonej odległości celu wynosiła 0,30 m do 0,39 m, a ważny wynik HR był dostępny w około 81–85% okien. Dla 13 czerwca trend A121 można bezpośrednio zestawić z Garminem; długich luk nie interpolowano.



Rysunek 13.7: Częstość oddechu w trzech pełnych nocach z płaską pokrywą. Estymata była dostępna w około 92–98% okien i przez większość czasu pozostawała w spójnym zakresie; tylko dla 13 czerwca zachował się równoległy eksport Garmina.

13.10 Pułapka interpretacyjna: amplituda dominującego odbicia

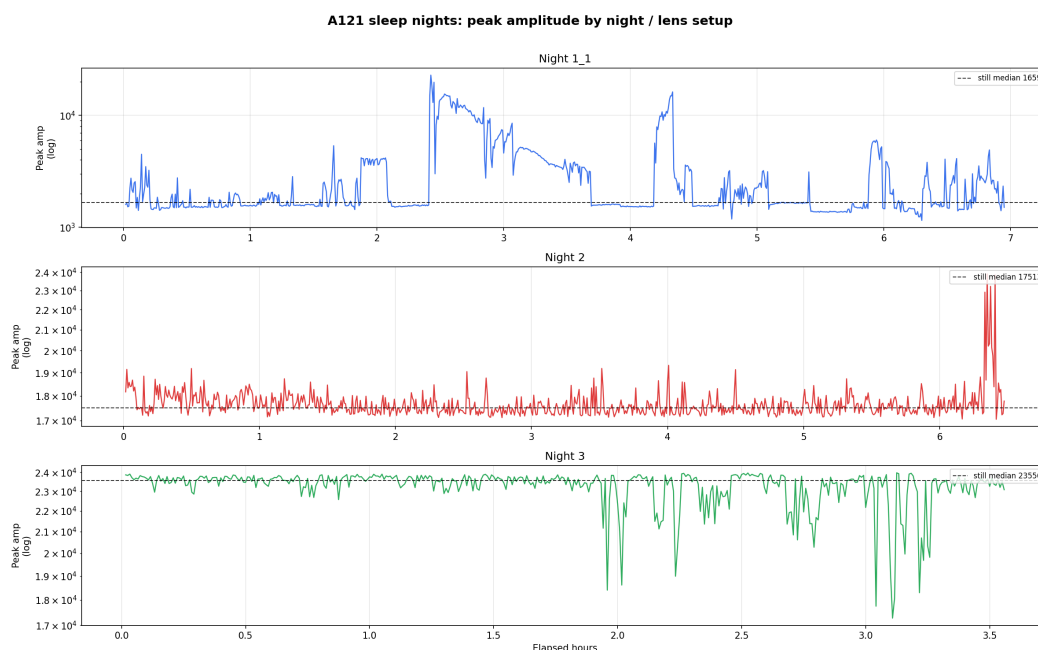
Tabela 13.7: Amplituda dominującego odbicia a zgodność z celem.

Noc	Mediana ampl. piku [j.u.]	Mediana odl. celu [m]	Mediana odl. piku [m]	Udział okien $ \Delta d \leq 0,10$ m
1	1665	0,37	0,15	0,316
2	17516	0,44	0,12	0,012
3	23574	0,22	0,10	0,384

Surowy wykres amplitud (rys. 13.8) sugeruje dramatyczną poprawę między nocami. Tabela 13.7 pokazuje jednak, dlaczego nie wolno tego czytać jako „lepszego sygnału z klatki piersiowej”: w nocy 2 jedynie **1,2%** okien miało dominujący pik w promieniu 10 cm od śledzonego celu. Silne odbicie pochodziło niemal na pewno od krawędzi łóżka lub innego bliskiego reflektora, a nie od badanego.

Z tego powodu w niniejszej pracy przyjęto następującą hierarchię wyników:

1. zgodność HR/RR z Garminem — wynik **podstawowy**,
2. zgodność faz snu — wynik **drugorzędny**,
3. surowa amplituda piku — wyłącznie **kontekst inżynierski**.



Rysunek 13.8: Amplituda dominującego odbicia w trzech nocach. Wykres jest użyteczny jako kontekst inżynierski, ale nie stanowi miary siły sygnału z klatki piersiowej.

13.11 Dyskusja wyników nocnych

Częstość oddechu była zgodna z wynikiem Garmina lepiej niż tętno. Jest to spójne z większą amplitudą ruchu oddechowego i mniejszymi wymaganiami na SNR; składowa sercowa jest słabsza i łatwiej ulega zakłóceniu przez ruch całego ciała, harmoniczne oddechu oraz zmianę dominującego reflektora.

W pomiarze nocnym początkowe skierowanie radaru na klatkę nie gwarantuje utrzymania tej geometrii przez wiele godzin. Badany zmienia pozycję, a klatka przesuwana się poprzecznie i obraca względem osi czujnika. Wąska wiązka soczewki skupiającej może wtedy dać wysoką amplitudę odbicia od niewłaściwego obiektu, podczas gdy szersze pole widzenia płaskiej pokrywy nadal obejmuje część tułowia. Taki mechanizm jest zgodny zarówno z najlepszą zgodnością tętna w nocy 3, jak i z ciągłymi przebiegami trzech późniejszych nocy nad łóżkiem. Nie wolno jednak przypisać całej poprawy samej pokrywie: jednocześnie zmieniono położenie radaru z boku łóżka na wysięgnik nad tułowiem. Wynik pokazuje przewagę *konkretnej pary* szeroka wiązka–tolerancyjna geometria, a nie uniwersalny ranking elementów optycznych.

Najważniejsze ograniczenia badania to jedna osoba, różne ustawienia między nocami, brak eksportu Garmina dla dwóch z trzech pełnych nocy nad łóżkiem oraz brak polisomnografii. Garmin jest konsumenckim źródłem porównania, a nie złym standardem. Z tego powodu wyników nie należy interpretować jako rankingu soczewek ani walidacji klinicznej algorytmu snu. Noc z soczewką hiperboliczną przy medianie 1,62 m pozostaje świadomie wyłączona z tych wniosków, ponieważ ponad 60° odchylenia od normalnej czyniło geometrię nieporównywalną.

[TODO: Powtórzyć pełną noc z soczewką hiperboliczną z większego dystansu, ustawiając oś możliwie prostopadle do klatki i dokumentując dystans oraz kąt. Porównać ją z płaską pokrywą przy tym samym mocowaniu nad łóżkiem; nie używać nieudanego nagrania ukośnego jako wyniku ujemnego soczewki.]

Rozdział 14

Dalsze zastosowania i eksperymenty

[TODO: Rozdział rezerwowany — na kolejne eksperymenty, które powstaną w trakcie pracy.]

14.1 Detekcja bezdechów

Miejsce zarezerwowane: Możliwość wykrywania pauz oddechowych z sygnału fazowego; kryteria (pauza >10 s), weryfikacja.

14.2 Pomiar na większych dystansach

Wstępny test na dystansie około 2 m wykazał, że soczewka plano-convex zwiększyła amplitudę tylko o około 13%, ale dała znacznie bardziej wiarygodną estymatę tętna (54,5 wobec 83,2 bpm dla wariantu bez soczewki). Jest to kolejny argument, że amplituda nie jest wystarczającym kryterium decyzyjnym. Planowany test granicy zasięgu wykorzystuje jedną soczewkę hiperboliczną, stałą konfigurację, oddech 0,2 Hz narzucony metronomem oraz odcinki wstrzymania oddechu. Granicę użyteczności należy zdefiniować przez trafienie zadanej częstości i SNR, a nie przez samą widoczność przebiegu.

14.3 Pomiar przez przeszkody

Wyniki literaturowe z sekcji 3.6 wskazują, że cienka, sucha odzież powinna mieć mniejszy wpływ niż zawilgocona tkanina albo wielowarstwowa kołdra. Należy jednak raportować konkretny materiał, grubość, wilgotność i kąt, ponieważ pojęcie „penetracji” bez tych danych jest niejednoznaczne. Praktycznym rozwinięciem jest prze-

platany pomiar bez przeszkody i przez tę samą suchą kłodę, oddzielnie dla HB100 i A121.

14.4 Wiele badanych i uogólnialność

Miejsce zarezerwowane: Wszystkie dotychczasowe wyniki pochodzą od jednego badanego. Rozszerzenie na grupę — kluczowe dla wiarygodności modeli uczonych.

14.5 Zastosowanie sieci neuronowych do klasyfikacji snu

Miejsce zarezerwowane: Zastąpienie heurystycznego klasyfikatora faz snu modelem uczonym na danych z Garmina jako etykietach; ograniczenia takiego podejścia (etykiety referencyjne same są estymatami).

Rozdział 15

Podsumowanie i wnioski końcowe

[TODO: Zebrać wnioski z części II i III, odnieść się do celów postawionych w rozdziale 1.]

Najważniejsze ustalenia inżynierskie uzyskane dotychczas:

- Zbudowano kompletny tor pomiarowy dla radaru HB100 — od analogowego wzmacniacza i filtru ($\approx 121\times$) po estymację parametrów vitalnych — oraz zintegrowano radar Acconeer A121 pracujący na surowych danych Sparse IQ.
- Na dystansie 0,5 m do 1,0 m system nie jest ograniczony amplitudą sygnału: SNR oddechowy wynosi 44–47 dB niezależnie od soczewki i obecności folii aluminiowej. Zysk anteny przekłada się na stabilność śledzenia celu, a nie na wykrywalność oddechu.
- Na dystansie 0,5 m do 1,0 m folia aluminiowa nie zwiększyła mierzalnie amplitudy odbicia. Z powodu wykonania warunków w osobnych sesjach wpływ folii na SNR pozostaje nierozstrzygnięty i wymaga krótkiego, przeplatanego retestu przy 2 m.
- W pomiarach nocnych zgodność częstości oddechu z Garmin Fenix 7 mieści się w granicach $\pm 0,5$ oddechu na minutę, a tętna w granicach kilku uderzeń na minutę. Rozbieżności w fazach snu wskazują na ograniczenia heurystycznego klasyfikatora — co jest bezpośrednią motywacją dla zastosowania sieci neuronowych.

15.1 Kierunki dalszych prac

Miejsce zarezerwowane: Sieci neuronowe do klasyfikacji faz oddechu (rozdział 12), rozszerzenie badania na wielu uczestników, walidacja względem polisomnografii.

Bibliografia

- [1] Acconeer AB, *Lens design — Acconeer docs*, dokumentacja techniczna A121, https://docs.acconeer.com/en/latest/integration/lens_design.html (dostęp: 15.07.2026).
- [2] Acconeer AB, *A121 documentation and software*, <https://developer.acconeer.com/home/a121-docs-software/> (dostęp: 15.07.2026).
- [3] Acconeer AB, *A121 Pulsed Coherent Radar Sensor Data Sheet*, wersja 1.8, <https://developer.acconeer.com/download/a121-datasheet/> (dostęp: 15.07.2026).
- [4] Acconeer AB, *Interpreting radar data — Sparse IQ*, https://docs.acconeer.com/en/latest/radar_data_and_control/a121/interpreting_radar_data.html (dostęp: 15.07.2026).
- [5] Waveshare, *A121 Range Sensor — documentation*, https://www.waveshare.com/wiki/A121_Range_Sensor (dostęp: 15.07.2026).
- [6] MILESEEEY, *D2 Laser Distance Meter — specifications*, <https://mileseeyrussia.ru/dalnomer-mileseey-d2/> (dostęp: 15.07.2026).
- [7] Infineon Technologies, *FMCW Radar Digital Signal Processing*, materiał szkoleniowy, https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-FMCW_RADAR_Digital_Signal_Processing_Handout-Training-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c8929aa4d018a178075b06be9 (dostęp: 15.07.2026).
- [8] J. W. Wallace, R. Mehmood, M. A. Jensen, *4–40 GHz Transmission Measurement of Indoor Building Materials at Normal Incidence*, 2018 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC/URSI National Radio Science Meeting, 2018, <https://doi.org/10.1109/APUSNCURSINRSM.2018.8609395>.
- [9] S. Y. Jun, D. Caudill, J. Chuang, P. B. Papazian, A. Bodi, C. Gentile, J. Senic, N. T. Golmie, *Penetration Loss at 60 GHz for Indoor-to-Indoor and Outdoor-to-*

- Indoor Mobile Scenarios*, 14th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), 2020, <https://doi.org/10.23919/EuCAP48036.2020.9135581>.
- [10] N. C. Albrecht, J. P. Weiland, D. Langer, M. Wenzel, A. Koelpin, *Characterization of the Influence of Clothing and Other Materials on Human Vital Sign Sensing using mmWave Radar*, 53rd European Microwave Conference (EuMC), 2023, <https://doi.org/10.23919/EuMC58039.2023.10290459>.
- [11] F. Landreani, A. Martin, C. Casellato, E. Pavan, C. Frigo, P.-F. Migeotte, A. Faini, G. Parati, E. Caiani, *Respiratory Frequency Estimation from Accelerometric Signals Acquired by Mobile Phone in a Controlled Breathing Protocol*, Computing in Cardiology, 2017, <https://doi.org/10.22489/CinC.2017.137-402>.
- [12] A. Nayak, M. Bolic, *Smartphone System for Heart Rate and Breathing Rate Estimation*, IEEE Open Journal of Instrumentation and Measurement, 2024, <https://doi.org/10.1109/OJIM.2024.3477572>.
- [13] STMicroelectronics, *LSM6DS3: iNEMO inertial module — data sheet*, <https://www.st.com/resource/en/datasheet/lsm6ds3.pdf> (dostęp: 15.07.2026).
- [14] Apple Inc., *CMMotionManager — Core Motion documentation*, <https://developer.apple.com/documentation/coremotion/cmmotionmanager> (dostęp: 15.07.2026).
- [15] Apple Inc., *deviceMotionUpdateInterval — Core Motion documentation*, <https://developer.apple.com/documentation/coremotion/cmmotionmanager/devicemotionupdateinterval> (dostęp: 15.07.2026).
- [16] **[TODO: Publikacja o dokładności szacowania faz snu przez zegarki Garmin względem polisomnografii.]**
- [17] Agilsense / ST Electronics, *HB100 Microwave Sensor Module Data Sheet*, https://www.theremino.com/wp-content/uploads/files/HB100_Microwave_Sensor_Module_Datasheet.pdf (dostęp: 15.07.2026).
- [18] Microchip Technology, *MCP6001/2/4 Operational Amplifier Data Sheet*, <https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MSLD/ProductDocuments/DataSheets/MCP6001-1R-1U-2-4-1-MHz-Low-Power-Op-Amp-DS20001733.pdf> (dostęp: 15.07.2026).
- [TODO: Uzupełnić pozostałą bibliografię do części klinicznej, optycznej, UWB i uczenia maszynowego.]**